

**PERATURAN DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS DISA PRIMA MEDIKA
NOMOR: 1085/DPM/I-PER/DIR/X/2025**

**TENTANG
PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS)**

DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS DISA PRIMA MEDIKA,

Menimbang : a. bahwa rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memerlukan tata kelola korporasi yang efektif dan efisien (*Good Corporate Governance*) guna menjamin mutu dan kelangsungan penyelenggaraan pelayanan;
b. bahwa sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan operasional, diperlukan penyesuaian tata kelola korporasi rumah sakit yang mampu menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan mendukung peningkatan kinerja rumah sakit;
c. bahwa untuk mengatur secara jelas hubungan, hak dan kewajiban, wewenang, serta tanggung jawab antara Pemilik Rumah Sakit atau yang mewakili, Pengelola Rumah Sakit, dan Staf Medis Fungsional, perlu ditetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Prima husada.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan di Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR PT. DISA PRIMA MEDIKA TENTANG
PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Peraturan Internal (Hospital Bylaws) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit secara keseluruhan, meliputi Peraturan Internal Korporasi (Corporate Bylaws) dan Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws).
2. Peraturan Internal Korporasi (Corporate Bylaws) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (corporate governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan struktur, wewenang, dan hubungan antara Pemilik, Dewan Pengawas, dan Pejabat Pengelola Rumah Sakit.
3. Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme Staf Medis di rumah sakit.
4. Dewan Pengawas adalah Dewan yang mewakili Pemilik, terdiri dari Ketua dan Anggota, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit oleh Pejabat Pengelola dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola.
5. Pemilik adalah entitas (Perseroan Terbatas Disa Prima Medika) atau pihak yang diwakilinya, yang memiliki dan bertanggung jawab atas kelangsungan Rumah Sakit.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Prima husada yang secara teknis medis dan teknis operasional memimpin, bertanggung jawab terhadap keberlangsungan operasional, dan mewakili Rumah Sakit.
7. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individual yang diberikan oleh Tenaga Medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi, dan tindakan.
8. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien yang berfungsi membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang medis lainnya.
9. Pelayanan Keperawatan adalah upaya profesional untuk membantu individu, baik yang sakit maupun yang sehat, dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi pengetahuan, kemauan, dan kemampuan.
10. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah perangkat non-struktural yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal, membantu pimpinan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan tanggung jawab sosial (Social Responsibility).
11. Komite Medis adalah perangkat rumah sakit non-struktural yang berfungsi menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis melalui mekanisme Kredensial, penjagaan mutu profesi medis, serta pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
12. Komite Etik dan Hukum adalah wadah non-struktural yang bertugas memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Direktur dalam hal penyusunan pedoman medikoetikolegal, penyelesaian masalah etika, pemeliharaan etika rumah sakit, dan gugus tugas bantuan hukum.
13. Staf Medis Fungsional (SMF) adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis yang melaksanakan pelayanan medis dan telah disetujui untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit Prima husada sesuai aturan yang berlaku.
14. Rapat Rutin Dewan Pengawas adalah setiap rapat terjadwal yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas, di luar Rapat Tahunan dan Rapat Khusus.
15. Rapat Tahunan Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pemilik atau Dewan Pengawas setahun sekali untuk mengevaluasi kinerja dan kebijakan umum Rumah Sakit.

16. Rapat Khusus Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pemilik atau Dewan Pengawas di luar jadwal rutin untuk mengambil keputusan mengenai hal-hal yang dianggap khusus atau mendesak.
17. Dokter adalah dokter dan/atau dokter spesialis yang melakukan pelayanan di Rumah Sakit Prima husada.
18. Dokter Tetap atau Dokter Purna Waktu adalah dokter dan/atau dokter spesialis yang sepenuhnya bekerja dan terikat secara kepegawaian di Rumah Sakit Prima husada.
19. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan berstatus sebagai pegawai Rumah Sakit, yang diundang/ditunjuk karena kompetensinya untuk memberikan pelayanan medis dan/atau tindakan medis untuk jangka waktu dan/atau kasus tertentu.
20. Dokter Kontrak dan/atau Dokter Honorer adalah dokter, baik dokter dan/atau dokter spesialis, yang diangkat dengan status tenaga kontrak dan/atau tenaga honorer di Rumah Sakit Prima husada dengan masa kerja untuk jangka waktu tertentu, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
21. Sub Komite adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Komite Medis atau Komite lain, yang bertugas untuk mengatasi masalah khusus, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas usul Komite yang bersangkutan.
22. Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu, yang dilaksanakan berdasarkan Penugasan Klinis (Clinical Appointment).
23. Penugasan Klinis (Clinical Appointment) adalah penugasan formal dari Direktur Rumah Sakit Prima husada kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis berdasarkan daftar Kewenangan Klinis yang telah ditetapkan baginya.
24. Kredensial (Credentialing) adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis (Clinical Privilege).
25. Rekredensial (Recredentialing) adalah proses re-evaluasi secara berkala terhadap staf medis yang telah memiliki Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) untuk menentukan kelayakan perpanjangan Kewenangan Klinis tersebut.
26. Audit Medis (Medical Audit) adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya, yang dilaksanakan oleh profesi medis.

BAB II PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT

Pasal 2 Nama dan Kedudukan

Rumah Sakit ini bernama :

1. Rumah Sakit Prima husada Kota Probolinggo yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No 10 Mayangan Kota Probolinggo. No. Telepon (0335) 422176.

Pasal 3 Tujuan, Visi, Misi dan Dasar Pelayanan

1. Tujuan Rumah Sakit Prima husada adalah:
 - a. Tujuan umum adalah terwujudnya derajat kesehatan setiap pasien yang dirawat di rumah sakit secara optimal dengan proses pelayanan rumah sakit yang prima, profesional, paripurna, dan terjangkau masyarakat sehingga memenuhi harapan masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkomitmen tinggi dan kemajuan Rumah Sakit;

- b. Tujuan khusus yaitu memberikan pelayanan medis spesialistik yang lengkap dan terjangkau masyarakat, pelayanan Rujukan spesialistik yang profesional, pelayanan Kesehatan yang tepat waktu, tepat sarana dan penuh empati, penurunan angka kematian rumah sakit, Kepuasan pasien, kesejahteraan semua karyawan Rumah Sakit.
2. Visi Rumah Sakit Prima husada adalah Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.
3. Misi Rumah Sakit Prima husada adalah:
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat, dan akurat;
 - b. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien;
 - c. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.
4. Falsafah Rumah Sakit Prima husada adalah Memberikan pelayanan secara profesional berlandaskan hati nurani yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.
5. Dasar Pelayanan Rumah Sakit atau juga disebut 7 Nilai Budi utama adalah: Jujur, Tanggung jawab, Visioner, Disiplin, Kerjasama, Adil dan peduli.

Pasal 4

Tugas, Pokok dan Fungsi Rumah Sakit

1. Pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan secara internal pada bidang pengelolaan sumber daya dan operasional pelayanan sesuai dengan standar rumah sakit;
2. Pembinaan fungsi pelayanan kesehatan yang meliputi sistem informasi manajemen (SIM), rekam medis dan pendidikan pelatihan SDM serta penelitian pengembangan;
3. Pelayanan medis dan keperawatan untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna;
4. Pelayanan penunjang medis dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna;
5. Penatausahaan dan urusan dalam kegiatan rumah sakit

Pasal 5

Asas Pelayanan

1. Transparansi adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
2. Akuntabilitas merupakan kejelasan, fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Rumah Sakit Prima husada agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Responsibilitas merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap pelayanan yang sehat serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Independensi merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENORGANISASIAN RUMAH SAKIT DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

Pengorganisasian

1. Struktur Organisasi adalah pembagian posisi jabatan, pembagian Tugas, Fungsi, Tanggung jawab dan Wewenang dalam organisasi.

2. Prosedur kerja menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
3. Pengelompokan fungsi pelayanan menggambarkan pembagian yang jelas antara prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
4. Pengelolaan Sumber daya manusia adalah pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

Pasal 7 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Rumah Sakit, terdiri dari:

1. Dewan Pengawas
2. Direktur Rumah Sakit
3. Kepala Bidang Pelayanan, terdiri dari:
 - a. Instalasi Rawat Inap;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Gawat Darurat;
 - d. Instalasi Kamar Operasi;
 - e. Intensive Care Unit.
4. Kepala Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - a. Instalasi Rawat Inap;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Gawat Darurat;
 - d. Instalasi Kamar Operasi;
 - e. Intensive Care Unit.
5. Kepala Bidang Penunjang, terdiri dari:
 - a. Instalasi Laboratorium;
 - b. Instalasi Radiologi;
 - c. Instalasi Farmasi;
 - d. Instalasi Rekam Medis;
 - e. Instalasi Gizi;
 - f. Instalasi CSSD dan Laundry;
 - g. Unit Pemulasaraan Jenazah.
6. Kepala Bidang Penunjang, terdiri dari:
 - a. Unit Keuangan dan Akuntansi;
 - b. Unit SDM dan Diklat;
 - c. Unit Humas dan Marketing;
 - d. Unit Umum dan Rumah Tangga;
 - e. Instalasi IT dan SIMRS;
 - f. Instalasi Asuransi Center;
 - g. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
7. Satuan Pengawas Internal
8. Sekretaris
9. Komite-komite dan Tim
10. Manajer Pelayanan Pasien

Pasal 8 Prinsip Tata Kelola

1. Rumah Sakit Prima husada beroperasi dengan pola tata kelola atau peraturan Internal yang meliputi:
 - a. Struktur Organisasi
 - b. Prosedur Kerja
 - 1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit Prima husada *Corporate* maupun dengan organisasi dalam lingkungan Perseroan Terbatas Disa Prima Medika sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - 2) Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Umum, Kepala Komite Medis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - 3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang umum, Kepala Komite Medis dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan;
 - 4) Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Umum, Kepala Komite Medis menyampaikan laporan kepada Direktur Rumah Sakit;
 - 5) Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Umum, Kepala Komite Medis dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi;
 - 6) Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Umum, Kepala Komite Medis wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.
 - c. Pengelompokan Fungsi Pelayanan
 - d. Pengelompokan Sumber Daya Manusia
2. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip:
 - a. Transparansi
 - b. Akuntabilitas
 - c. Responsibilitas
 - d. Independensi

BAB IV DEWAN PENGAWAS

Pasal 9 Organisasi Dewan Pengawas

1. Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur pemilik Rumah Sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahsakit, dan tokoh masyarakat.
2. Unsur pemilik Rumah Sakit ditunjuk oleh pemilik Rumah Sakit.
3. Unsur organisasi profesi ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit setelah berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan.
4. Unsur asosiasi perumahsakit, ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit setelah berkoordinasi dengan asosiasi perumahsakit.
5. Unsur tokoh masyarakat merupakan tenaga ahli di bidang perumahsakit.

6. Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah maksimal 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

Pasal 10

Kualifikasi Dewan Pengawas

1. Memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit.
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
5. Berusia minimal 40 tahun (PP Nomor 49 Tahun 2013).
6. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
7. Mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
8. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemilik Rumah Sakit.

Pasal 11

Pengangkatan, Penilaian dan Pemberhentian

1. Masa jabatan anggota Dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
2. Pengangkatan anggota Dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola rumah sakit.
3. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh pemilik.
4. Penilaian kinerja Dewan Pengawas oleh pemilik setiap tahun
5. Pemberhentian Anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit atau; dan
 - d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/ atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Rumah Sakit.

Pasal 12

Tugas Dewan Pengawas

1. Melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pejabat pengelola rumah sakit, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan.
2. Pelaksaa tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilaksanakan dengan:
 - a. Menghadiri rapat Dewan Pengawas;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada pejabat pengelola rumah sakit dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada pejabat pengelola rumah sakit mengenai perbaikan tata kelola rumah sakit;

- d. Mengawasi dan memberikan pendapat dan/ atau saran kepada pejabat pengelola rumah sakit atas pelaksanaa rencana strategis bisnis dan rencan bisnis dan anggaran;
- e. Memberikan pendapat dan/ atau saran atas laporan berkala rumah sakit antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan internal;
- f. Menyusun program kerja tahunan pengawasan rumah sakit; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tanggung Jawab Dewan Pengawas

1. Laporan pengawasan sebagai berikut:
 - a. Laporan semester pertama paling lambat 30 hari setelah periode semester berakhir;
 - b. Laporan semester kedua (tahunan) paling lambat 40 hari setelah tahun anggaran berakhir.
2. Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Penilaian terhadap Renstra, RBA dan pelaksanaannya;
 - b. Penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan lainnya;
 - c. Penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan;
 - d. Permasalahan - permasalahan pengelolaan rumah sakit dan solusinya; dan
 - e. Saran dan rekomendasi.
3. Menyetujui dan mengkaji visi misi rumah sakit secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi rumah sakit.
4. Menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional rumah sakit yang diperlukan untuk berjalannya rumah sakit sehari-hari.
5. Menyetujui partisipasi rumah sakit dalam pendidikan profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi mutu dari program-program tersebut.
6. Menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dan memenuhi misi serta rencana strategis rumah sakit.
7. Melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan.
8. Mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
9. Melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program PMKP setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.
10. Melakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.

Pasal 14

Wewenang Dewan Pengawas

11. Menerima laporan berkala atas pengelolaan rumah sakit, antara lain laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur Rumah Sakit;
12. Menerima laporan hasil pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Saki dengan sepengetahuan Direktur dan memantau rekomendasi tindak lanjut;

13. Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola Rumah Sakit dalam pelaksanaan kegiatan rumah sakit;
14. Mendapatkan penjelasan dari Pejabat Pengelola Rumah Sakit dan/ atau manajemen lainnya mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan rumah sakit;
15. Memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam rapat Pejabat Pengelola Rumah Sakit; dan
16. Melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V DIREKTUR RUMAH SAKIT

Pasal 15 Kualifikasi Direktur

1. Seorang Dokter yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan.
2. Pendidikan S2 Magister Manajemen
3. STR dan SIP Aktif
4. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit,
5. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit.
6. Bersedia membuat Surat Pemyataan Kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat di Rumah Sakit.

Pasal 16 Pengangkatan dan Penilaian Direktur

1. Direktur Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan Surat Keputusan.
2. Masa bakti Direktur selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Utama.
3. Penilaian kinerja Direktur oleh pemilik/representasi pemilik setiap tahun

Pasal 17 Pemberhentian Direktur

1. Pemberhentian Direktur dapat dilakukan karena:
 - a. Telah habis masa jabatannya
 - b. Diberhentikan oleh Direktur Utama sebelum habis masa jabatan.
2. Direktur dapat diberhentikan oleh Direktur Utama karena:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan kegiatan operasional Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit Prima husada.
3. Pemberhentian Direktur ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama.

Pasal 18 Tugas Direktur

1. Memimpin, menjalankan, dan mengelola perusahaan sesuai dengan Undang – Undang, peraturan yang berlaku serta anggaran dasar perusahaan.
2. Melakukan fungsi manajemen meliputi perencanaan, kebijakan, pembuatan keputusan, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan segenap aktivitas di rumah sakit.
3. Merekomendasikan kebijakan – kebijakan kepada dewan pengawas.
4. Mengumumkan visi dan misi rumah sakit ke publik.
5. Menyetujui rancangan anggaran keuangan tahunan, usulan pengembangan bisnis (termasuk kompetensi SDM), proposal penyesuaian kompensasi kemitraan dengan dokter spesialis serta remunerasi karyawan.
6. Memelihara, menanggapi/merespon hubungan yang harmonis antara instansi pemerintah, swasta, organisasi yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan.

Pasal 19
Tanggung Jawab Direktur

1. Mematuhi perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjalankan visi dan misi rumah sakit yang telah ditetapkan.
3. Menetapkan kebijakan rumah sakit.
4. Memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh Regulator.
5. Mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya.
6. Merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada representatif pemilik/dewan pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
7. Menetapkan prioritas perbaikan tingkat rumah sakit yaitu perbaikan yang akan berdampak luas/menyeluruh di rumah sakit yang akan dilakukan pengukuran sebagai indikator mutu prioritas rumah sakit.

Pasal 20
Wewenang Direktur

1. Memimpin dan mengelola Rumah Sakit sesuai dengan tujuan Rumah Sakit, dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna.
2. Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola Rumah Sakit sebagaimana yang telah digariskan oleh Pemilik/ Direktur Utama.
3. Mengendalikan pengelolaan Rumah Sakit dengan berwawasan lingkungan.
4. Membuat laporan tahunan dan atau laporan berkala kepada Perseroan Terbatas.
5. Menggunakan, memelihara dan mengelola aset Rumah Sakit.
6. Mewakili Rumah Sakit baik di dalam dan di luar Pengadilan.
7. Menetapkan kebijakan anggaran modal dan operasional rumah sakit.
8. Menetapkan Kebijakan dan prosedur, menyetujui pendidikan, penelitian dan pengembangan para profesional di bidang kesehatan.
9. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit.
10. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi Rumah Sakit sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi Rumah Sakit.
11. Menyetujui kebijakan dan prosedur serta menyetujui pendidikan para profesional kesehatan dan penelitian.
12. Mengangkat dan memberhentikan tenaga kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tenaga kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Mengangkat dan memberhentikan dokter, dokter spesialis dan pegawai Rumah Sakit sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Menetapkan dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dokter, dokter spesialis dan pegawai rumah Sakit sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Mendelegasikan kewenangan untuk memberikan persetujuan.
17. Dalam melaksanakan tugasnya direktur dibantu oleh Kepala Bagian.

BAB VI DIREKSI RUMAH SAKIT

Pasal 21 Organisasi

1. Direksi Rumah Sakit adalah seluruh pejabat struktural baik Direktur, Kepala Bidang, dan Kepala Bagian maupun Satuan Pengawas Internal pada Rumah Sakit yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Rumah Sakit.
2. Direktur Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
3. Direktur bertanggungjawab terhadap operasional rumah sakit kepada Direktur Utama.
4. Komposisi Direksi Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya setelah dilakukan analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan dengan mengusulkan kepada Direktur Utama.
5. Perubahan komposisi Direksi rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 22 Kualifikasi dan Tugas Direksi

1. Standar Kualifikasi Satuan Pengawas Internal:
 - a. Seseorang berpendidikan minimal dokter/ dokter spesialis;
 - b. Berpengalaman sebagai Kepala Bidang minimal 3 tahun;
 - c. Memiliki pelatihan yang berhubungan dengan perumahsakit;
 - d. Satuan Pengawas Internal (SPI) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
 - e. Satuan Pengawas Internal (SPI) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- f. Tugas Satuan Pengawas Internal:
 - 1) Melakukan kajian dan analisa terhadap rencana investasi rumah sakit khususnya sejauh mana uraian pengkajian dan pengelolaan risiko telah dilaksanakan oleh unit yang lain;
 - 2) Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, pemantauan, efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur, dalam bidang keuangan, operasi dan pelayanan, pemasaran, sumber daya manusia dan pengembangan rumah sakit;
 - 3) Melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian informasi dan komunikasi yang meliputi:
 - a) Informasi penting rumah sakit terjamin keamanannya;
 - b) Fungsi sekretariat rumah sakit dalam pengendalian;
 - c) Informasi dapat berjalan dengan efektif;
 - d) Penyajian laporanJaporan rumah sakit memenuhi peraturan dan perundang-undangan;

- e) Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan Direktur.
- 2. Standar Kualifikasi Kepala Bidang Pelayanan Medis:
 - a. Seorang berpendidikan minimal dokter;
 - b. Pernah menjadi kepala IGD minimal 3 tahun;
 - c. Mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan dan manajemen pelayanan medis
 - d. Tugas Kepala Bidang Pelayanan Medis:
 - 1) Menyusun rencana dan program kegiatan pelayanan dalam rangka penetapan kebijakan Rumah Sakit;
 - 2) Merumuskan kebijakan teknis pelayanan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
 - 3) Mengkoordinasikan semua kegiatan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku kepada bawahan;
 - 4) Mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Medical Staff by Laws;
 - 5) Mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas di Bidang Pelayanan Medis dan keperawatan;
 - a) Mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan.
 - b) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - c) Melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d) Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan;
 - e) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.
- 3. Standar Kualifikasi Kepala Bidang Keperawatan:
 - a. Seorang berpendidikan Sarjana Keperawatan/S2.
 - b. Pernah menjadi kepala unit rawat inap, rawat jalan, dan IGD minimal 3 tahun;
 - c. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kepemimpinan dan manajemen keperawatan.
 - d. Tugas Kepala Bidang Keperawatan:
 - 1) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan seluruh kebutuhan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
 - 2) Perencanaan segala kebutuhan, baik administratif medis dan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk tenaga medis, tenaga kesehatan keperawatan dan tenaga kesehatan profesi lainnya;
 - 3) Pemantauan, pengawasan, penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan;
 - 4) Pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien;
 - 5) Penyelenggaraan asuhan keperawatan; dan
 - 6) Peningkatan etika keperawatan, pengembangan dan pengendalian mutu keperawatan.
- 4. Standar Kualifikasi Kepala Bidang Penunjang Medis:
 - a. Seorang berpendidikan minimal dokter;
 - b. Pernah menjadi kepala unit laboratorium atau kamar operasi minimal 3 tahun;
 - c. Mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan dan manajemen penunjang medis.
 - d. Tugas Bidang Penunjang Medis:
 - 1) Menyusun rencana dan program kegiatan pelayanan dalam rangka penetapan kebijakan Rumah Sakit;

- 2) Merumuskan kebiakan teknis pelayanan serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
 - 3) Mengkoordinasikan semua kegiatan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku kepada bawahan;
 - 4) Mengkoordinasikan penyusunan dan mengawasi pelaksanaan Medical Staff by Laws;
 - 5) Mengawasi, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas-tugas di penunjang medis;
 - 6) Mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan;
 - 7) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - 8) Melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - 9) Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan;
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - 11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.
5. Standar Kualifikasi Kepala Bagian Umum dan Keuangan:
- a. Seorang berpendidikan Sarjana (Ekonomi/ Manajemen/ Akuntansi/ Ekonomi Kesehatan).
 - b. Berpengalaman di bidang administrasi dan Umum minimal 3 tahun.
 - c. Mengikuti pelatihan-pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Rencana Strategis, Rencana Implementasi, dan Rencana Tahunan, Sistem Rekrutmen Pegawai, Sistem Remunerasi, Sistem Informasi, Rencana Bisnis Anggaran.
 - d. Tugas Kepala Bagian Umum dan Keuangan:
 - 1) Menyusun rencana dan program kerja Rumah Sakit.
 - 2) Merumuskan kebijakan umum Rumah Sakit serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan.
 - 3) Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kegiatan administrasi umum, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, bina program, kepegawaian, pengembangan SDM.
 - 4) mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan perencanaan strategis (RENSTRA) serta profil Rumah Sakit dan laporan tahunan Rumah Sakit.
 - 5) Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban kinerja Rumah Sakit.
 - 6) Mengkoordinasikan penyusunan Tata Kelola Rumah Sakit dan Hospital Bylaws.
 - 7) Mengatur mendistribusikan mengkoordinasikan tugas kepada bawahan.
 - 8) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan.
 - 9) Melaksanakan pengawasan terhadap urusan administrasi umum, keuangan, tata usaha.
 - 10) Menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sarana prasarana tenaga, peralatan dan bahan kebutuhan lainnya.
 - 11) Melaksanakan pengawasan terhadap kebersihan, keamanan dan kenyamanan kantor.
 - 12) Melaksanakan pengawasan terhadap urusan kepegawaian, dan pelatihan
 - 13) Melaksanakan sistem pengendalian internal.
 - 14) Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan.
 - 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
 - 16) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.

Pasal 23
Rapat Direksi

1. Rapat pemilik dengan direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (bulan) bulan sekali.
2. Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali.
3. Rapat kepala bidang dengan kepala instalasi/ unit sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali
4. Dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan rumah sakit sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
5. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan konsultasi direksi dengan representasi pemilik.
6. Rapat kinerja tahunan antara pemilik dengan Direksi Rumah Sakit sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
7. Untuk setiap rapat harus dibuat undangan, notulen dan daftar hadir.

Pasal 24
Kebijakan Teknis Operasional

Direktur berwenang untuk menetapkan berbagai ketentuan dan peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan peraturan yang meliputi peraturan Rumah Sakit, peraturan tentang kepegawaian Rumah Sakit, pengendalian pasien dan pengunjung serta masalah lain yang dianggap perlu.

BAB VII
KOMITE DAN TIM

Pasal 25
Pembentukan Komite dan Tim

1. Direksi Rumah Sakit dalam mengawal mutu pelayanan kesehatan berbasis keselamatan pasien maka perlu dibentuk komite-komite yang merupakan wadah profesional dan memiliki otoritas dalam organisasi staf medis, keperawatan, etik dan hukum, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), farmasi dan terapi serta dalam rangka mengembangkan pelayanan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pembentukan komite dan tim yaitu:
 - a. Komite Medis;
 - b. Komite Keperawatan;
 - c. Komite Tenaga Kesehatan Lain;
 - d. Komite K3RS;
 - e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
 - f. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien;
 - g. Komite Farmasi dan Terapi;
 - h. Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA);
 - i. Komite Etik;
 - j. Tim Review Rekam Medis;
 - k. Tim PONEK;
 - l. Tim TB DOTS;
 - m. Tim HIV
 - n. Tim Geriatri
 - o. Tim KB

- p. Tim Stunting dan Wasting
 - q. Tim HTA
3. Komite dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan non struktural yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.

KOMITE MEDIS

Pasal 26

Pembentukan Komite Medis

1. Komite medis dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi;
2. Komite Medis merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di rumah sakit;
3. Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medis.
4. Pembentukan Komite Medis Rumah Sakit ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur Rumah Sakit.
5. Pembentukan Komite Medis untuk pertama kali, Ketua Komite Medis ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 27

Struktur Organisasi Komite Medis

1. Komite Medis adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok staf medis atau yang mewakili.
2. Komite Medis mempunyai otoritas tertinggi di dalam pengorganisasian staf medis. Komite medis berada dibawah Direktur Rumah Sakit.
3. Susunan Komite Medis terdiri dari Ketua, Wakil ketua, sekretaris, dan anggota.

Pasal 28

Kualifikasi Komite Medis

1. Ketua Komite Medis
 - a. Bisa dijabat oleh dokter purna waktu atau dokter paruh waktu yang dipilih secara demokratis oleh ketua-ketua kelompok staf medis.
 - b. Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Komite Medis oleh Direktur Rumah Sakit.
 - c. Ketua Komite Medis memilih Sekretaris Komite Medis.
 - d. Ketua Komite Medis dapat menjadi Ketua dari salah satu Ketua Sub Komite.
 - e. Persyaratan untuk menjadi Ketua Komite Medis sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai Kredibilitas yang tinggi dalam profesinya;
 - 2) Mempunyai segi ilmu profesinya dalam jangkauan, ruang lingkup, sasaran dampak yang luas;
 - 3) Peka terhadap perkembangan perumahnyasakit;
 - 4) Bersifat terbuka bijaksana dan jujur;
 - 5) Mempunyai kepribadian yang dapat di terima dan disegani dilingkungan profesinya;
 - 6) Mempunyai integritas keilmuan dan etika profesi yang tinggi.
2. Sekretaris
 - a. Sekretaris Komite Medis dipilih oleh Ketua Komite Medis;
 - b. Rumah sakit dengan jumlah dokter terbatas maka sekretaris Komite Medis dapat dipilih dari salah satu anggota Komite Medis;

- c. Sekretaris Komite Medis dapat menjadi ketua dari salah satu sub Komite. Dalam menjalankan tugasnya. Sekretaris Komite Medis dibantu oleh tenaga administrasi (staf sekretariat).
3. Jumlah keanggotaan Komite Medis sebagaimana disesuaikan dengan jumlah staf medis di rumah sakit.

Pasal 29 Tugas Komite Medis

Fungsi Komite Medis adalah sebagai pengarah (*steering*) dalam pemberian pelayanan medis, sedangkan staf medis adalah pelaksana medis.

1. Tugas
 - a. Membantu Direktur Rumah Sakit menyusun standar pelayanan medis dan memantau
 - b. Pelaksanaannya;
 - c. Melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin, dan mutu profesi;
 - d. Mengatur kewenangan Profesi antar Kelompok staf medis;
 - e. Membantu Direktur Rumah Sakit menyusun Medical Staff Bylaws dan memantau pelaksanaannya;
 - f. Membantu Direktur Rumah Sakit menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan medis-legal;
 - g. Membantu Direktur Rumah Sakit menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan etik-legal;
 - h. Melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit;
 - i. Melakukan koordinasi dengan Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dalam melaksanakan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf medis;
 - j. Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis;
 - k. Melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis antara lain monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan (drug usage) farmasi dan terapi, ketepatan, kelengkapan dan keakuratan rekam medis, tissue review mortalitas, morbiditas, medical care review, peer review, audit medis melalui pembentukan sub komite;
 - l. Memberikan laporan kegiatan kepada Direktur Rumah Sakit.
2. Dalam melaksanakan tugas kredensial Komite Medis memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dan pengkompilasian daftar Kewenangan Klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku.
 - b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
 - 1) Kompetensi;
 - 2) Kesehatan fisik dan mental;
 - 3) Perilaku;
 - 4) Etika profesi.
 - c. Evaluasi data pendidikan profesional kedokteran berkelanjutan.
 - d. Wawancara terhadap permohonan Kewenangan Klinis.
 - e. Penilaian dan keputusan Kewenangan Klinis.
 - f. Pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi Kewenangan Klinis kepada Komite Medis
 - g. Melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku Surat Penugasan Klinis dan adanya permintaan dari Komite Medis.
 - h. Rekomendasi Kewenangan Klinis dan penerbitan Surat Penugasan Klinis.

3. Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis, Komite Medis memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan audit medis;
 - b. Rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - c. Rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit.
 - d. Rekomendasi proses pendampingan bagi staf medis yang membutuhkan.
4. Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis, Komite Medis memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. Pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - c. Rekomendasi pendisiplinan perilaku profesional di rumah sakit;
 - d. Pemberian nasehat / pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Pasal 30

Tanggung Jawab Komite Medis

Tanggung jawab Komite Medis kepada Direktur Rumah Sakit adalah terkait dengan mutu pelayanan medis, pembinaan etika kedokteran dan pengembangan profesi medis yaitu :

1. Mendukung komunikasi yang efektif antar tenaga professional.
2. Menyusun kebijakan, pedoman , prosedur serta protoko , tata hubungan kerja alur klinis dan dokumen lain yang menagtir layanan klinis.
3. Menyusun kode etik profesi, dan
4. Memantau mutu pelayanan pasien lainnya.

Pasal 31

Wewenang Komite Medis

1. Memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis/ delineation of clinical privilege.
2. Memberikan rekomendasi surat penugasan klinis/ clinical appointment.
3. Memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis/ clinical privilege.
4. Memberikan rekomendasi perubahan / modifikasi rincian kewenangan klinis/ delineation of clinical privilege.
5. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis.
6. Memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan.
7. Memberikan rekomendasi pendampingan/ proctoring.
8. Memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

Pasal 32

Kewajiban Komite Medis

1. Menyusun peraturan Internal Medis (Medical Staf Bylaws).
2. Membuat standarisasi format untuk standar pelayanan medis, Standar Prosedur Operasional di bidang manajerial/ administrasi dan bidang keilmuan/ profesi, standar profesi dan standar kompetensi.
3. Membuat standarisasi format pengumpulan, pemantauan, pelaporan, indikator mutu klinik.
4. Melakukan pemantauan mutu klinik, etika kedokteran dan pelaksanaan pengembangan profesi medis.

Pasal 33
Masa Kerja Komite Medis

1. Ketua, Wakil ketua dan Sekretaris Komite Medis mempunyai masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan kemudian dapat dipilih kembali atas dasar musyawarah dan mufakat ketua dan Anggota Staf Medis.
2. Hasil pemilihan disahkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 34
Tata Kerja Komite Medis

1. Tata Kerja Komite Medis secara Administratif
 - a. Rapat rutin Komite Medis dilakukan 1 kali 1 bulan;
 - b. Rapat Komite Medis dengan semua kelompok staf medis dan atau dengan semua tenaga dokter dilakukan minimal 1 (satu) kali 1 (satu) bulan;
 - c. Rapat komite medis dengan Direktur Rumah Sakit/ Kabid pelayanan dilakukan minimal 1 (satu) kali 1 (satu) bulan;
 - d. Rapat darurat, diselenggarakan untuk masalah mendesak dilakukan sesuai kebutuhan;
 - e. Menetapkan tugas dan kewajiban sub komite, termasuk pertanggungjawabannya terhadap suatu progam.
2. Tata Kerja Komite Medis secara Teknis
 - a. Mengkaitkan perjanjian kerja dokter di rumah sakit dengan kewenangan komite medis sebagai peer profesi medis di Rumah Sakit;
 - b. Menjabarkan hubungan antara komite medis sebagai nilai kompetensi dan etika profesi dengan manajemen Rumah Sakit sebagai pemegang kewenangan pengelolaan Rumah Sakit;
 - c. Koordinasi antara Komite Medis dengan Direktur Rumah Sakit dalam menangani masalah tenaga dokter serta pengaturan penyampaian informasi pada pihak diluar seperti perkumpulan profesi dan pihak lain non profesi seperti kepolisian dan jajaran hukum.

Pasal 35
Sub Komite Medis

1. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dibantu oleh Sub Komite. Sub Komite dibentuk di sesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit.
2. Sub Komite terdiri dari:
 - a. Sub Komite Kredensial;
 - b. Sub Komite Mutu Profesi Medis;
 - c. Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi.

Pasal 36
Sub Komite Kredensial

1. Untuk memproteksi masyarakat, Komite Medis memiliki peran melakukan penapisan (kredensial/ rekredensial) bagi seluruh staf medis di rumah sakit melalui Sub Komite Kredensial.
2. Pengorganisasian Sub Komite Kredensial terdiri dari:
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.

3. Proses kredensial dilaksanakan dengan semangat keterbukaan, adil, obyektif sesuai prosedur dan terdokumentasi;
4. Sub Komite Kredensial melakukan penilaian kompetensi seorang staf medis dan menyiapkan berbagai instrumen kredensial yang disahkan Direktur. Instrumen tersebut paling sedikit meliputi kebijakan rumah sakit tentang kredensial dan Kewenangan Klinis, pedoman penilaian kompetensi klinis, formulir yang diperlukan;
5. Pada akhir proses kredensial, Komite Medis menerbitkan rekomendasi kepada Direktur tentang lingkup Kewenangan Klinis seorang staf medis;
6. Sub Komite Kredensial melakukan rekredensial bagi setiap staf medis yang mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku Surat Penugasan Klinis.

Pasal 37

Tata Kerja Subkomite Kredensial

1. Staf medis mengajukan permohonan Kewenangan Klinis kepada Direktur dengan mengisi formulir daftar rincian Kewenangan Klinis yang telah disediakan rumah sakit dengan dilengkapi bahan-bahan pendukung;
2. Berkas permohonan staf medis yang telah lengkap disampaikan oleh Direktur kepada Komite Medis;
3. Kajian terhadap formulir daftar rincian Kewenangan Klinis yang telah diisi oleh pemohon;
4. Pengkajian oleh Subkomite Kredensial meliputi elemen:
 - a. Kompetensi:
 - 1) Berbagai area kompetensi sesuai standar kompetensi yang disahkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk itu;
 - 2) Kognitif;
 - 3) Afektif;
 - b. Psikomotor;
 - Kompetensi fisik;
 - c. Kompetensi mental/perilaku; dan
 - d. Perilaku etis.
5. Kewenangan Klinis yang diberikan mencakup derajat kompetensi dan cakupan praktik;
6. Daftar rincian Kewenangan Klinis diperoleh dengan cara:
 - a. Menyusun daftar Kewenangan Klinis dilakukan dengan meminta masukan dari setiap Kelompok Staf Medis;
 - b. Mengkaji Kewenangan Klinis bagi pemohon dengan menggunakan daftar rincian Kewenangan Klinis; dan
 - c. Mengkaji ulang daftar rincian Kewenangan Klinis bagi staf medis dilakukan secara periodik;
7. Rekomendasi pemberian Kewenangan Klinis dilakukan oleh Komite Medis berdasarkan masukan dari Sub Komite Kredensial;
8. Sub Komite Kredensial melakukan rekredensial bagi setiap staf medis yang mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku Surat Penugasan Klinis (SPK) dengan rekomendasi berupa:
 - a. Kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan;
 - b. Kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah;
 - c. Kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi;
 - d. Kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu; kewenangan klinis yang bersangkutan diubah/ dimodifikasi; dan
 - e. Kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri;

9. Bagi staf medis yang ingin memulihkan Kewenangan Klinis yang dikurangi atau menambah Kewenangan Klinis yang dimiliki dapat mengajukan permohonan kepada Komite Medis melalui Direktur. Selanjutnya, Komite Medis menyelenggarakan pembinaan profesi antara lain melalui mekanisme pendampingan (proctoring).

Pasal 38
Sub Komite Mutu Profesi

1. Untuk menjaga mutu profesi para staf medis, Komite Medis mempunyai peran melakukan audit medis, merekomendasikan pendidikan berkelanjutan dan memfasilitasi proses pendampingan staf medis melalui Sub Komite Mutu Profesi.
2. Pengorganisasian Sub Komite Mutu Profesi terdiri dari:
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.

Pasal 39
Tata Kerja Sub Komite Profesi

1. Pelaksanaan audit medis harus dapat memenuhi 4 (empat) peran penting yaitu:
 - a. Sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi masing-masing staf medis pemberi pelayanan di rumah sakit;
 - b. Sebagai dasar untuk pemberian Kewenangan Klinis/ Clinical Privilege sesuai kompetensi yang dimiliki;
 - c. Sebagai dasar bagi Komite Medis dalam merekomendasikan pencabutan atau penangguhan Kewenangan Klinis/ Clinical Privilege;
 - d. Sebagai dasar bagi Komite Medis dalam merekomendasikan perubahan/ modifikasi rincian Kewenangan Klinis seorang staf medis.
2. Langkah-langkah pelaksanaan audit medis:
 - a. Pemilihan topik yang akan dilakukan audit;
 - b. Penetapan standar dan kriteria, penetapan jumlah kasus,/ sampel yang akan diaudit;
 - c. Membandingkan standar/ kriteria dengan pelaksanaan pelayanan;
 - d. Melakukan analisis kasus yang tidak sesuai standar dan kriteria;
 - e. Menerapkan perbaikan;
 - f. Rencana reaudit.
3. Subkomite Mutu Profesi dapat merekomendasikan pendidikan berkelanjutan bagi staf medis:
 - a. Menentukan pertemuan ilmiah yang harus dilaksanakan oleh masing-masing kelompok staf medis dengan pengaturan waktu yang disesuaikan;
 - b. Pertemuan tersebut dapat pula berupa pembahasan kasus antara lain meliputi kasus kematian (death case), kasus sulit maupun kasus langka;
 - c. Setiap kali pertemuan ilmiah harus disertai notulensi, kesimpulan dan daftar hadir peserta yang akan dijadikan pertimbangan dalam penilaian disiplin profesi;
 - d. Notulensi beserta daftar hadir menjadi dokumen/ arsip Sub Komite Mutu Profesi;
 - e. Sub Komite Mutu Profesi bersama-sama dengan kelompok staf medis menentukan kegiatan ilmiah yang akan dibuat oleh Sub Komite Mutu Profesi yang melibatkan staf medis Rumah Sakit sebagai narasumber dan peserta aktif;
 - f. Setiap kelompok staf medis wajib menentukan minimal satu kegiatan ilmiah yang akan dilaksanakan dengan Sub Komite Mutu Profesi pertahun;

- g. Sub Komite Mutu Profesi bersama dengan bagian pendidikan dan penelitian Rumah Sakit memfasilitasi kegiatan tersebut dan dengan mengusahakan satuan angka kredit dari ikatan profesi;
 - h. Menentukan kegiatan ilmiah yang dapat diikuti oleh masing-masing staf medis setiap tahun dan tidak mengurangi hari cuti tahunannya;
 - i. Memberikan persetujuan terhadap permintaan staf medis sebagai asupan kepada Manajemen.
4. Sub Komite Mutu Profesi dapat memfasilitasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan:
 - a. Menentukan nama staf medis yang akan mendampingi staf medis yang sedang mengalami sanksi disiplin/ mendapatkan pengurangan Kewenangan Klinis;
 - b. Komite medis berkoordinasi dengan Direktur untuk memfasilitasi semua sumber daya yang dibutuhkan untuk proses pendampingan (proctoring) tersebut.

Pasal 40

Sub Komite Etika Dan Disiplin Profesi

1. Peran Komite Medis dalam upaya pendisiplinan staf medis dilakukan oleh Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi.
2. Pengorganisasian Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

Pasal 41

Tata Kerja Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi memiliki semangat yang berlandaskan:
 - a. Peraturan internal rumah sakit;
 - b. Peraturan internal staf medis;
 - c. Etika rumah sakit;
 - d. Norma etika medis dan norma-norma bioetika.
2. Tolak ukur dalam upaya pendisiplinan perilaku profesional staf medis yaitu:
 - a. Pedoman pelayanan kedokteran di rumah sakit;
 - b. Prosedur kinerja pelayanan di rumah sakit;
 - c. Daftar Kewenangan Klinis di rumah sakit;
 - d. Kode etik kedokteran Indonesia;
 - e. Pedoman perilaku profesional kedokteran/ buku penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik;
 - f. Pedoman pelanggaran disiplin kedokteran yang berlaku di Indonesia;
 - g. Pedoman pelayanan medis/ klinik;
 - h. Standar prosedur operasional asuhan medis.
3. Penegakan disiplin profesi dilakukan oleh sebuah panel yang dibentuk oleh Ketua Sub Komite Etika dan Disiplin profesi. Panel terdiri dari 3 orang staf medis atau lebih dalam jumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang dari Sub Komite Etika dan Disiplin profesi yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda dari yang diperiksa;
 - b. 2 (dua) orang atau lebih staf medis dari disiplin ilmu yang sama dengan yang diperiksa dapat berasal dari dalam rumah sakit atau luar rumah sakit, baik atas permintaan Komite Medis dengan persetujuan Direktur.

4. Mekanisme pemeriksaan pada upaya pendisiplinan perilaku profesional, adalah sebagai berikut:
- a. Sumber laporan:
 - 1) Perorangan:
 - a) Manajemen rumah sakit;
 - b) Staf medis lain;
 - c) Tenaga kesehatan lain atau tenaga non kesehatan;
 - d) Pasien atau keluarga pasien.
 - 2) Non perorangan:
 - a) Hasil konferensi kematian;
 - b) Hasil konferensi klinis.
 - b. Dasar dugaan pelanggaran disiplin profesi menyangkut hal-hal antara lain:
 - 1) Kompetensi klinis;
 - a) Penatalaksanaan kasus medis;
 - b) Pelanggaran disiplin profesi;
 - c) Penggunaan obat dan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit;
 - d) Ketidakmampuan bekerja sama dengan staf rumah sakit yang dapat membahayakan pasien;
 - 2) Pemeriksaan:
 - a) Dilakukan oleh panel pendisiplinan profesi;
 - b) Melalui proses pembuktian;
 - c) Dicatat oleh petugas sekretariat Komite Medis;
 - d) Terlapor dapat didampingi oleh personil dari rumah sakit tersebut;
 - e) Panel dapat menggunakan keterangan ahli sesuai kebutuhan;
 - f) Seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh panel disiplin profesi bersifat tertutup dan pengambilan keputusannya bersifat rahasia.
 - 3) Keputusan:

Keputusan panel yang dibentuk oleh Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi diambil berdasarkan suara terbanyak, untuk menentukan ada atau tidak pelanggaran disiplin profesi kedokteran di rumah sakit. Bilamana terlapor merasa keberatan dengan keputusan panel, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya dengan memperbarui kepada Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi yang kemudian akan membentuk panel baru. Keputusan ini bersifat final dan dilaporkan kepada Direktur.
 - 4) Rekomendasi pemberian tindakan pendisiplinan profesi pada staf medis oleh Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi di Rumah Sakit berupa:
 - a) Peringatan tertulis;
 - b) Limitasi (reduksi) Kewenangan Klinis;
 - c) Bekerja dibawah supervisi dalam waktu tertentu oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk pelayanan medis tersebut;
 - d) Pencabutan Kewenangan Klinis sementara atau selamanya.
 - e) Pelaksanaan Keputusan:

Keputusan Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi tentang pemberian tindakan disiplin profesi diserahkan kepada Direktur oleh Ketua Komite Medis sebagai rekomendasi, selanjutnya Direktur melakukan eksekusi.
 - 5) Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi menyusun materi kegiatan pembinaan profesionalisme kedokteran. Pelaksanaan pembinaan profesionalisme kedokteran dapat diselenggarakan dalam bentuk ceramah, diskusi, simposium, lokakarya yang dilakukan oleh unit kerja rumah sakit seperti unit pendidikan dan penelitian atau Komite Medis.

- 6) Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi mengadakan pertemuan pembahasan kasus dengan mengikutsertakan pihak-pihak terkait yang kompeten untuk memberikan pertimbangan pengambilan keputusan etis.

Pasal 42

Rapat Rutin Komite Medis

1. Rapat Komite Medis terdiri dari:
 - a. Rapat rutin bulanan dilakukan bersama dengan staf medis yang diselenggarakan setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - b. Rapat koordinasi dengan pejabat pengelola Rumah Sakit yang diselenggarakan minimal dalam 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. Rapat khusus, dilakukan sewaktu-waktu guna membahas yang sifatnya urgent; dan
 - d. Rapat tahunan, diselenggarakan sekali setiap tahunan.
2. Rapat Rutin dipimpin oleh Ketua Komite Medis atau Sekretaris apabila ketua tidak dapat hadir.
3. Rapat Rutin dinyatakan sah apabila dihadiri oleh pating sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Komite Medis atau dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai maka Rapat dinyatakan sah setelah ditunda dalam batas waktu 15 menit, selanjutnya rapat dianggap kuorum.
4. Setiap Rapat khusus dan rapat tahunan wajib dihadiri oleh Direksi Rumah Sakit dan pihak pihak lain yang ditentukan oleh Ketua Komite Medis.
5. Keputusan rapat komite medis didasarkan atas suara terbanyak.
6. Dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka Ketua berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang.
7. Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota Komite Medis yang hadir.
8. Direktur dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap keputusan yang diambil pada Rapat Rutin, Rapat Khusus sebelumnya dengan syarat usul tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat.
9. Dalam hal usulan perubahan atau pembatalan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima dalam rapat maka usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut.

Pasal 43

Rapat Khusus Komite Medis

1. Rapat khusus diadakan dalam hal :
 - a. Adanya permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota staf medis dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sebelumnya.
 - b. Adanya keadaan/ situasi tertentu yang medesak untuk segera dilaksanakan Rapat Komite Medis
2. Undangan rapat khusus harus disampaikan oleh ketua kepada peserta rapat paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum dilaksanakan.
3. Undangan rapat khusus harus dicantumkan tujuan pertemuan spesifik.
4. Rapat khusus yang diminta untuk anggota staf medis sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan tersebut.

Pasal 44

Rapat Tahunan Staf Medis dan Komite Medis

1. Rapat tahunan Kelompok Staf Medis dan atau Komite Medis diselenggarakan sekali dalam setahun.

2. Ketua menyampaikan undangan tertulis kepada anggota dan laporan lain paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan.

Pasal 45
Undangan Rapat

Setiap rapat dinyatakan sah apabila undangan telah disampaikan secara pantas, kecuali seluruh anggota yang berhak memberikan suara menolak undangan tersebut.

Pasal 46
Peserta Rapat

Peserta rapat adalah anggota Komite Medis yang diundang oleh Ketua Komite Medis atau yang berhak mewakili dan atau pihak lain yang ditentukan oleh Komite Medis.

Pasal 47
Pejabat Ketua

Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir dalam suatu rapat dan kuorum telah tercapai maka anggota Staf Medis dan atau Komite Medis dapat memilih pejabat Ketua untuk memimpin rapat.

Pasal 48
Kuorum

1. Rapat Kelompok Staf Medis dan atau Komite Medis dapat dilaksanakan apabila kuorum tercapai.
2. Kuorum di anggap tercapai apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Kelompok Staf Medis.
3. Dalam hal Kuorum tidak tercapai dalam waktu 1 (satu) jam dalam waktu rapat yang telah ditentukan maka rapat dapat di tangguhkan untuk dilanjutkan pada suatu tempat, waktu dan hari yang lain.
4. Dalam hal kuorum juga tidak tercapai dalam waktu 1 (satu) jam dan waktu yang telah ditentukan pada waktu berikutnya, maka rapat di lanjutkan dan segala keputusan yang ada dalam risalah rapat di sahkan dalam anggota Kelompok Staf Medis dan atau Komite Medis berikutnya.

Pasal 49
Pemungutan Suara

1. Setiap masalah yang diputuskan melalui pemungutan suara dalam rapat Kelompok Staf Medis dan atau Komite Medis yang di tentukan dengan mengangkat tangan atau bila di hendaki oleh anggota Kelompok Staf Medis dan atau Komite Staf medis, pemungutan dapat dilakukan dengan amplop tertutup.
2. Keputusan rapat Kelompok Staf Medis dan atau Komite Medis didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara.
3. Dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka Ketua atau Wakil Ketua berwenang untuk menyelenggarakan pemungutan suara kedua kalinya.
4. Perhitungan suara hanyalah berasal dari anggota Kelompok Staf Medis dan atau Komite Staf Medis yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 50
Pembatalan Keputusan Rapat

1. Direktur dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap keputusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya dengan syarat usul perubahan atau pembatalan tersebut di cantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini.
2. Dalam hal khusus perubahan atau pembatalan keputusan Direktur Rumah Sakit tidak diterima dalam rapat tersebut maka usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu 3 (bulan) terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut.

KOMITE KEPERAWATAN

Pasal 51
Pembentukan Komite Keperawatan

1. Dalam rangka mewujudkan tata kelola klinis yang baik, setiap Rumah Sakit harus membentuk Komite Keperawatan;
2. Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Direktur;
3. Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan;
4. Komite Keperawatan dibentuk oleh Direktur;
5. Susunan organisasi Komite Keperawatan terdiri dari:
 - a. Ketua Komite Keperawatan;
 - b. Sekretaris Komite Keperawatan; dan
 - c. Sub Komite.
6. Keanggotaan Komite Keperawatan terbagi kedalam Subkomite:
 - a. Sub komite kredensial bertugas melakukan kredensial untuh semua staf keperawalan yang memberika pelayanan Rumah Sakit;
 - b. Sub komite mutu profesi bertugas mempertahankan mutu profesi semua staf keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit;
 - c. Sub komite etik profesi bertugas mempertahankan dan memberikan pembinaan etik dan disiplin kepada staf keperawatan yang memberikan pelayanan di Rumah Sakit.

Pasal 52
Pemilihan Pengurus Komite Keperawatan

1. Ketua Keperawatan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di rumah sakit.
2. Sekretaris dan Sub Komite diusulkan oleh Ketua Komite Keperawatan dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit.

Pasal 53
Tugas Komite Keperawatan

1. Komite Keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam melakukan kredensial, pembinaan disiplin dan etika profesi tenaga keperawatan serta pengembangan profesi berkelanjutan;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Komite Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan konsultasi keperawatan;

- b. Penyelenggaraan tukar pendapat, kebijakan dan pelaksanaan pelayanan;
- c. Pemberian motivasi dalam pemecahan masalah profesi keperawatan melalui pembelajaran;
- d. Penggalan inovasi dan ide-ide yang membangun dan pembaharuan kearah perbaikan profesi keperawatan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran kepada profesi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki;
- f. Penyelenggaraan advokasi dengan memberikan perlindungan dan dukungan kepada profesi dalam menerima hak-haknya termasuk masalah hukum.

Pasal 54

Wewenang Komite Keperawatan

1. Membuat dan membubarkan panitia kegiatan keperawatan (panitia Ad Hoc) secara mandiri maupun bersama Bidang Keperawatan.
2. Mengusulkan rencana kebutuhan tenaga keperawatan dan proses penempatan tenaga keperawatan berdasarkan tinjauan profesi.
3. Mengusulkan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana keperawatan.
4. Membimbing perawat dalam kesuksesan kerja dan karir.
5. Memberikan pertimbangan tentang bimbingan dan konseling Keperawatan.

Pasal 55

Sub Komite

1. Ketua Sub Komite ditetapkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Keperawatan dengan memperhatikan masukan dari staf keperawatan yang bekerja di rumah sakit.
2. Sub Komite yang ada di Rumah Sakit terdiri atas:
 - a. Sub Komite Kredensial;
 - b. Sub Komite Mutu Profesi;
 - c. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi.

Pasal 56

Sub Komite Kredensial

1. Sub Komite Kredensial mempunyai tugas:
 - a. Menyusun daftar rincian kewenangan klinis;
 - b. Menyusun buku putih;
 - c. Menerima hasil verifikasi persyaratan kredensial;
 - d. Merekomendasikan tahapan proses kredensial;
 - e. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis bagi setiap tenaga keperawatan;
 - f. Melakukan kredensial ulang secara berkala setiap 3 (tiga) tahun;
 - g. Membuat laporan seluruh proses kredensial kepada Ketua
 - h. Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur.
2. Dalam menjalankan tugasnya, Sub Komite Kredensial dapat mengusulkan dibentuknya team ad hoc, kepada semua komite keperawatan.

Pasal 57

Sub Komite Mutu Profesi

1. Sub Komite Mutu Profesi mempunyai tugas:
 - a. Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktek:

- b. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan;
 - c. Melakukan audit asuhan keperawatan;
 - d. Memfasilitasi proses pendampingan tenaga keperawatan sesuai kebutuhan.
2. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut dalam pasal 70 ayat (1), Sub Komite Mutu Profesi dapat mengusulkan dibentuknya team add hoc kepada Ketua Komite Keperawatan baik insidental atau permanen.

Pasal 58

Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi

1. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi mempunyai tugas:
 - a. Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;
 - b. Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan;
 - c. Melakukan penegakan disiplin profesi keperawatan;
 - d. Merekomendasikan penyelesaian masalah-masalah pelanggaran disiplin dan masalah-masalah etik dalam kehidupan profesi dan asuhan keperawatan;
 - e. Merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis dan/atau Surat penugasan klinis;
 - f. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan.

Pasal 59

Rapat

1. Komite Keperawatan dan Bidang Keperawatan melaksanakan kerja dan koordinasi secara berkala dan berkesinambungan melalui rapat koordinasi keperawatan.
2. Rapat Koordinasi Keperawatan terdiri dari : Rapat Kerja, Rapat Rutin, Rapat Pleno, dan Sidang tahunan.
3. Rapat Kerja:
 - a. Rapat Kerja Keperawatan dilaksanakan dalam setahun sekali dan bersifat terbuka,
 - b. Rapat Kerja Keperawatan dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan atau Kepala Bidang Keperawatan dan dihadiri oleh Sekretaris Komite Keperawatan;
 - c. Sub komite, keperawatan, panitia-panitia keperawatan dan kepala ruang keperawatan;
 - d. Agenda rapat kerja adalah membuat rencana kerja keperawatan dalam 1 (satu) tahun.
4. Rapat Rutin
 - a. Rapat rutin keperawatan dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali diikuti oleh Bidang Keperawatan, Komite Keperawatan, Kepala Ruang Keperawatan dan seluruh anggota Komite Keperawatan;
 - b. Agenda rapat rutin adalah membahas masalah- masalah Keperawatan;
 - c. Rapat rutin Keperawatan dipimpin oleh Kepala Bidang Keperawatan atau Ketua Komite Keperawatan.
5. Rapat Pleno
 - a. Rapat pleno keperawatan diadakan sewaktu-waktu bila dibutuhkan;
 - b. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan atau Kepala Bidang Keperawatan dan dihadiri oleh Sekretaris Komite Keperawatan, Sub Komite Keperawatan;
 - c. Agenda rapat pleno adalah membahas persoalan etik dan disiplin staf keperawatan.

6. Sidang Tahunan

- a. Sidang tahunan Keperawatan diadakan satu kali dalam setahun;
- b. sidang Tahunan dipimpin oleh Ketua Komite Keperawatan atau Kepala Bidang Keperawatan dan dihadiri oleh Sekretaris Komite Keperawatan, Sub Komite, Panitia-Panitia Keperawatan dan Kepala Ruang Keperawatan,
- c. Agenda sidang tahunan adalah membuat rencana kerja keperawatan dalam 1 (satu) tahun dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang telah lalu;
- d. Keputusan yang diambil harus disetujui sekurang- kurangnya oleh 2/3 peserta yang hadir.

KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN

Pasal 60

1. Komite Tenaga Kesehatan Lain adalah wadah organisasi non structural yang berfungsi mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keteknisan kesehatan agar staf tenaga kesehatan lainnya di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi keteknisan kesehatan, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi masing-masing
2. Komite Tenaga Kesehatan Lain bertanggung jawab langsung kepada direktur
3. Komite Tenaga Kesehatan lain terdiri dari:
 - a. Radiografer
 - b. Ahli gizi
 - c. Rekam Medis
 - d. Apoteker
 - e. Fisioterapis
 - f. Laboratorium
 - g. BDRS
4. Susunan personalia organisasi Komite Tenaga Kesehatan lain terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Sub Komite
5. Komite Tenaga Kesehatan Lain mempunyai tugas:
 - a. Mengembangkan strategi pelayanan, Pendidikan, pelatihan dan penelitian
 - b. Mengembangkan pengetahuan dan teknologi Keteknisian Kesehatan
 - c. Melakukan kredensial dan rekredensial terhadap Tenaga Kesehatan Lain
 - d. Memelihara mutu profesi
6. Komite Tenaga Kesehatan Lain mempunyai wewenang:
 - a. Memberikan rekomendasi rincian kewenangan kerja klinis
 - b. Memberikan rekomendasi pelatihan profesi berkelanjutan
 - c. Mengusulkan rencana kebutuhan tenaga kesehatan lain dan proses penempatan tenaga kesehatan lain berdasarkan tinjauan profesi.
 - d. Mengusulkan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tenaga kesehatan lain.

KOMITE K3RS

Pasal 61

1. Komite K3RS diharapkan mampu melakukan pencegahan kecelakaan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja serta dapat mengendalikan bahaya kebakaran dan bencana;
2. Komite K3 mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mengolah seluruh data dan informasi serta permasalahan yang berhubungan dengan K3 Rumah Sakit;
- b. Membantu Direktur dalam mengadakan dan meningkatkan upaya promosi K3, pelatihan dan penelitian K3 di Rumah Sakit;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan program K3;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan yang berkaitan dengan tindakan korektif;
- e. Koordinasi dengan unit-unit lain yang menjadi anggota K3;
- f. Memberi nasehat tentang manajemen K3 di tempat kerja, kontrol bahaya, mengeluarkan peraturan dan inisiatif pencegahan;
- g. Berpartisipasi dalam perencanaan peralatan baru, pembangunan gedung dan proses.

KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)

Pasal 62

1. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dibentuk guna membantu Kepala dalam pencegahan dan pengendalian infeksi.
2. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) mempunyai tugas:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - b. Menyusun serta menetapkan, mensosialisasikan dan mengevaluasi kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi (ppl);
 - c. Melaksanakan investigasi dan penanggulangan masalah Kejadian Luar Biasa (KLB) bersama Tim pencegahan dan Pengendali Infeksi Rumah Sakit;
 - d. Merencanakan, mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi dan aman bagi yang menggunakan;
 - e. Membuat pedoman tata laksana pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - f. Melaksanakan pemantauan terhadap upaya pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - g. Memberikan penyuluhan masalah infeksi kepada tenaga medis, non medis dan tenaga lainnya serta pengguna jasa rumah sakit;
 - h. Menerima laporan atas kegiatan tim ppl dan membuat laporan berkala kepada Direktur.
3. Komite PPI merupakan badan non struktural yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.
4. Komite PPI dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit setelah mempertimbangkan masukan dari Kepala Bidang.

KOMITE MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 63

Organisasi dan Keanggotaan

1. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dibentuk oleh Direktur rumah Sakit;
2. Susunan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, terdiri dari:
 - a. Ketua Komite
 - b. Sub Komite:
 - 1) Sub Komite Mutu;
 - 2) Sub Komite Keselamatan Pasien.
3. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien sebagai motor penggerak penyusun program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;

4. Dalam pelaksanaan tugas Komite Mutu dan Keselamatan Pasien bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.

Pasal 64

Tugas Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

1. Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan merencanakan program PMKP bersama Direktur Rumah Sakit;
 - b. Menyusun dan merencanakan pelaksanaan kegiatan program PMKP;
 - c. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan operasional PMKP secara efektif, efisien dan bermutu;
 - d. Menganalisa data indikator mutu pelayanan baik Indikator Mutu Klinis Rumah Sakit maupun Indikator Mutu monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PMKP;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PMKP;
 - f. Melaksanakan analisis terhadap data yang dikumpulkan dan diubah menjadi informasi;
 - g. Melakukan validasi data PMKP secara internal dan dilakukan secara periodik;
 - h. Menyebarkan informasi tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara regular melalui papan pengumuman, bulletin atau rapat staf(informasi mencakup proyek baru, hasil riset terkini atau program pereontohan);
 - i. Meningkatkan pengetahuan anggota dengan memberikan pelatihan terhadap staf yang ikut serta dalam program PMKP;
 - j. (1 0) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan PMKP kepada Direktur Rumah Sakit.
2. Ketua Sub Komite Mutu
 - a. Membuat perencanaan program kegiatan peningkatan mutu Rumah Sakit;
 - b. Membuat panduan peningkatan mutu Rumah Sakit;
 - c. Menentukan indikatr mutu Rumah Sakit bersama Direktur Rumah Sakit dan unit kerja;
 - d. Membuat panduan pencatatan dan pelaporan indikator mutu Rumah Sakit (klinis, manajemen dan sasaran keselamatan pasien);
 - e. Memimpin pertemuan berkala dengan anggota Sub Komite Mutu;
 - f. Membuat panduan analisa dan validasi;
 - g. Membuat panduan clinical pathway bersama komite medis;
 - h. Melaksanakan program kegiatan peningkatan mutu Rumah Sakit;
 - i. Membuat dan melakukan evaluasi kebijakan peningkatan mutu Rumah Sakit;
 - j. Melakukan evaluasi program kegiatan peningkatan mutu Rumah Sakit dan unit kerja;
 - k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu kepada Direktur Rumah Sakit;
 - l. Menyampaikan rekomendasi dari Direktur Rumah Sakit kepada anggota Komite PMKP dan unit yang terkait;
 - m. Melakukan pertemuan berkala dengan Ketua PMKP.
3. Ketua Sub Komite Keselamatan Pasien
 - a. Membuat perencanaan program kegiatan keselamatan pasien Rumah Sakit;
 - b. Membuat panduan keselamatan pasien Rumah Sakit;
 - c. Membuat panduan pencatatan dan pelaporan insiden keselamatan pasien (IKP) Rumah Sakit;
 - d. Membuat panduan manajemen risiko;
 - e. Membuat panduan FMEA dan RCA;
 - f. Memimpin pertemuan berkala dengan anggota Sub Komite Keselamatan Pasien;

- g. Membuat SPO yang terkait dengan program keselamatan pasien Rumah Sakit;
- h. Melaksanakan program keselamatan pasien Rumah Sakit;
- i. Melaksanakan pengukuran budaya keselamatan Rumah Sakit;
- j. Membuat dan melakukan evaluasi kebijakan keselamatan pasien Rumah Sakit
- k. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan keselamatan pasien Rumah Sakit;
- l. Bersama Direktur dan unit yang terkait melakukan RCA;
- m. Melakukan koordinasi tentang laporan insiden keselamatan pasien dengan Kepala unit terkait untuk menentukan risk grading dan tindak lanjut;
- n. Membuat laporan insiden keselamatan pasien kepada Direktur Rumah Sakit, Kepala Bidang, dan Ketua PMKP dalam rapat kerja bulanan;
- o. Melakukan pertemuan berkala dengan Ketua PMKP.

KOMITE FARMASI DAN TERAPI

Pasal 65

1. Komite Farmasi dan Terapi dibentuk guna membantu Direktur dalam rangka mencapai budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional.
2. Komite Farmasi dan Terapi mempunyai tugas:
 - a. Membuat pedoman diagnosis dan terapi, formularium rumah sakit, pedoman penggunaan antimikroba;
 - b. Melaksanakan pendidikan dalam bidang pengelolaan dan penggunaan obat terhadap pihak-pihak terkait;
 - c. Melaksanakan pengkajian pengelolaan dan penggunaan obat serta memberikan umpan balik;
 - d. Membina hubungan kerja dengan unit terkait didalam rumah sakit yang sasarannya berhubungan dengan obat;
 - e. Mengkaji penggunaan produk obat baru atau dosis obat yang diusulkan oleh anggota staf medis;
 - f. Mengelola obat yang digunakan dalam katagori khusus;
 - g. Membantu instalasi farmasi dalam mengembangkan tinjauan terhadap kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan mengenai penggunaan obat sesuai peraturan yang berlaku secara lokal maupun nasional.
3. Komite Farmasi dan Terapi merupakan badan non struktural yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Direktur.
4. Komite Farmasi dan Terapi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mempertimbangkan masukan dari Kepala Bidang.

KOMITE PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA

Pasal 65

1. Komite PPRA bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan penggunaan antimikroba, pencegahan dan penyebaran bakteri yang resisten serta pengendalian resistensi bakteri terhadap antimikroba. Pada setiap kepanitiaan tersebut, apoteker berperan penting dalam meningkatkan penggunaan antimikroba yang bijak.
2. Komite PPRA mempunyai tugas:
 - a. Menerapkan kebijakan-kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba (integrasi dengan 4 pilar);
 - b. Menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan antimikroba;
 - c. Menetapkan program pengendalian resistensi antimikroba (PPRA);
 - d. Memonitor dan mengevaluasi PPRA;

- e. Menyelenggarakan forum diskusi/ kajian pengelolaan penderita penyakit infeksi;
 - f. Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip pengendalian;
 - g. resistensi antimikroba yang terkait dengan penggunaan antimikroba secara bijak
 - h. Mengembangkan penelitian yang terkait dengan PPRA.
3. Komite PPRA mempunyai wewenang :
 - a. Menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit infeksi terintegrasi;
 - b. Melakukan surveilans pola penggunaan antibiotik;
 - c. Melakukan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik;
 - d. Menyebarluaskan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi melalui kegiatan pendidikan pelatihan;
 - e. Mengembangkan penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba;
 - f. Melaporkan kegiatan program pengendalian resistensi antimikroba kepada Direktur.

KOMITE ETIK DAN HUKUM

Pasal 66

1. Komite Etik dan Hukum dibentuk guna membantu Direktur untuk mensosialisasikan kewajiban rumah sakit kepada semua unsur yang ada di rumah sakit meliputi kewajiban umum rumah sakit, kewajiban rumah sakit terhadap masyarakat, kewajiban rumah sakit terhadap staf, menyelesaikan masalah medisolegal dan etika rumah sakit serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang ditunjuk Direktur dalam menyelesaikan masalah medisolegal.
2. Komite Etik dan Hukum merupakan badan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
3. Komite Etik dan Hukum dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur setelah mempertimbangkan masukan dari para Kepala Bidang.
4. Dalam melaksanakan tugas Panitia Etik dan Hukum berfungsi:
 - a. Menyelenggarakan dan meningkatkan komunikasi medis-etikolegal, baik internal maupun eksternal Rumah Sakit;
 - b. Menyelenggarakan dan meningkatkan pengetahuan etika dan hukum bagi petugas;
 - c. menyelenggarakan dan meningkatkan kemampuan risiko manajemen terhadap masalah-masalah etika dan hukum di Rumah Sakit.
5. Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (4) disampaikan secara tertulis kepada Direktur dalam bentuk rekomendasi.
6. Bahan pertimbangan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah berdasarkan penugasan dari Direktur.

REKAM MEDIS

Pasal 66

1. Tim Review Rekam Medis bertanggung jawab terhadap mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya di Unit Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis.
2. Tim Review Rekam Medis mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan untuk Penyusunan rancangan kebijakan Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis;
 - b. Menyusun program kerja dan anggaran di Unit Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis;
 - c. Menyusun SPO pelayanan di Unit Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis;
 - d. Menghadiri rapat rutin Rumah Sakit;
 - e. Menghadiri rapat rutin dengan atasan langsung;
 - f. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Rumah Sakit di Unit Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis;
 - g. Melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan program kerja serta kegiatan operasional di pelayanan Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis;
 - h. Mengevaluasi dan menyusun laporan kinerja dan anggaran di unit Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis;
 - i. Melakukan koordinasi dalam kegiatan atau proses dan pelayanan pasien rawat jalan atau rawat inap.
3. Tim Review Rekam medis mempunyai wewenang:
- a. Mengatur rencana kegiatan penyelenggaraan Unit Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis;
 - b. Memberikan penilaian kinerja dan memotivasi anggota di Unit Sistem Manajemen dan Rekam Medis;
 - c. Mengusulkan diklat SDM di Unit Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis;
 - d. Mengusulkan sarana prasarana ,alat dan logistik di Unit Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis.

TIM PONEK

Pasal 67

1. Tim PONEK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan program PONEK sesuai dengan pedoman PONEK yang berlaku
2. Tim PONEK mempunyai tugas untuk:
 - a. Menyusun regulasi terkait penerapan program Tim PONEK
 - b. Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan perlindungan ibu dan bayi secara terpadu
 - c. Mengembangkan kebijakan dan standar pelayanan ibu dan bayi
 - d. Meningkatkan kesiapan Rumah Sakit dalam melaksanakan fungsi pelayanan obstetric dan neonates termasuk pelayanan kegawat daruratan (PONEK 24 JAM)
 - e. Meningkatkan fungsi Rumah Sakit sebagai model dan Pembina teknis dalam pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif serta Perawatan Metode Kanguru (PMK) pada BBLR
 - f. Meningkatkan fungsi Rumah Sakit sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan ibu dan bayi bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya.
 - g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program RSSIB 10 langkah menyusui dan peningkatan kesehatan ibu
 - h. Melakukan pemantauan dan analisis yang meliputi:
 - 1) Angka keterlambatan operasi section caesaria
 - 2) Angka kematian ibu dan anak
 - 3) Kejadian tidak dilakukannya inisiasi menyusui dini (IMD pada bayi baru lahir

3. Tim PONEK mempunyai wewenang untuk:
 - a. Memerintahkan dan menugaskan staf dalam melaksanakan Program pelayanan obstetric neonatal emergency komprehensif
 - b. Meminta laporan pelaksanaan program pelayanan obstetric neonatal emergency komprehensif di rumah sakit dari unit kerja terkait
 - c. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Prima husada terkait pelaksanaan program pelayanan obstetric neonatal emergency komprehensif di rumahsakit
 - d. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan pelayanan obstetric neonatal emergency komprehensif di rumah sakitdari unit-unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Prima husada
 - e. Melakukan komunikasi internal dan eksternal kepada unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Prima husada dan pihak luar melalui surat tertulis, email, dan telepon

TIM TB DOTS

Pasal 68

1. Tim TB DOTS bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan TB Paru dan program TB paru di Rumah Sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Tim TB DOTS mempunyai tugas:
 - a. Menyusun regulasi terkait penerapan program Tim TB DOTS
 - b. Melakukan promosi kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai TB kepada pasien dan keluarga, pengunjung serta staf rumah sakit
 - c. Melaksanakan surveilans tuberculosis untuk memperoleh data epidemiologi yang diperlukand alam system informasi program penanggulangan TB seperti pencatatan dan pelaporan tuberculosis resistensi obat
 - d. Melakukan pengendalian factor risiko tuberculosis semuai dengan pedoman pengendalian pencegahan infeksi tuberculosis di Rumah Sakit
 - e. Melakukan monitoring dan memandu penerapan program Pengendalian tuberculosis di unit kerja
 - f. Memberikan obat pencegahan dan kekebalan melalui pemberian imunisasi
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian obat dan imunisasi
3. Tim TB DOTS mempunyai wewenang:
 - a. Meminta data dan informasi dari anggota terkait program TB DOTS
 - b. Memutuskan kebijakan yang berlaku untuk program TB DOTS sesuai perundangan atau regulasi yang berlaku
 - c. Meminta laporan pelaksanaan program pelayanan TB DOTS di Rumah Sakit dari unit kerja pelaksana/ terkait
 - d. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan RS Prima husada terkait pelaksana program pelayanan TB DOTS di Rumah Sakit
 - e. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan pelayanan TB DOTS di Rumah Sakit dari unit-unit kerja di lingkungan RS Prima husada

Tim HIV

Pasal 69

4. Tim HIV bertanggung jawab dalam melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai standar pelayanan dalm peraturan perundang-undangan.
5. Tim HIV bertugas untuk:
 - a. Sebagai motor penggerak penyusunan program Tim HIV/AIDS rumah sakit;

- b. Melakukan monitoring dan memandu penerapan program Tim HIV/AIDS di unit kerja.
 - c. Menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait serta menyampaikan masalah terkait pelaksanaan program Tim HIV/AIDS.
 - d. Menyusun regulasi terkait penerapan program Tim HIV/AIDS.
 - e. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan Tim HIV/AIDS di seluruh rumah sakit.
 - f. Terlibat dalam komunikasi masalah pelayanan HIV/AIDS
 - g. Mengintegrasikan sistem pelaporan kegiatan pelayanan HIV/AIDS
 - h. Melakukan pengawasan dan supervisi kemajuan pengumpulan data pengukuran untuk prioritas yang dipilih RS.
6. Tim HIV mempunyai wewenang:
- a. Meminta data dan informasi dari anggota terkait program HIV
 - b. Memutuskan kebijakan yang berlaku untuk program HIV sesuai perundangan atau regulasi yang berlaku
 - c. Meminta laporan pelaksanaan program pelayanan HIV di Rumah Sakit dari unit kerja pelaksana/ terkait
 - d. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan RS Prima husada terkait pelaksana program pelayanan HIV di Rumah Sakit
 - e. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan pelayanan HIV di Rumah Sakit dari unit-unit kerja di lingkungan RS Prima husada

Tim Geriatri
Pasal 70

1. Tim Geriatri bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan geriatric di Rumah Sakit sesuai dengan kemampuan, sumber daya dan sarana prasarana Rumah Sakit.
2. Tim Geriatri mempunyai tugas:
 - a. Merencanakan / membuat rencana kerja kebutuhan tim geriatri setiap tahunnya.
 - b. Menyelenggarakan pelayanan geriatri berdasarkan rencana kebutuhan ketenagaan, sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh direktur rumah sakit.
 - c. Menyelenggarakan rujukan, baik di dalam maupun ke dan dari luar rumah sakit.
 - d. Menyelenggarakan kerjasama dengan tim / departemen / bagian / KSMF (Kelompok Staf Medik Fungsional) lain di rumah sakit, serta hubungan lintas program dan lintas sektoral melalui direktur rumah sakit.
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan geriatric di Rumah Sakit
 - f. Melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi dalam bentuk laporan
 - g. Memberikan laporan berkala tim terpadu geriatri kepada Direktur Rumah Sakit
 - h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan upaya pelayanan geriatri sesuai dengan tingkatan pelayanan.
 - i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dengan berbagai disiplin.
 - j. Memberikan pembinaan terhadap komunitas terkait.
3. Tim Geriatri mempunyai wewenang:
 - a. Meminta data dan informasi dari anggota terkait program Geriatri
 - b. Memutuskan kebijakan yang berlaku untuk program Geriatri sesuai perundangan atau regulasi yang berlaku

- c. Meminta laporan pelaksanaan program pelayanan Geriatri di Rumah Sakit dari unit kerja pelaksana/ terkait
- d. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan RS Prima husada terkait pelaksana program pelayanan Geriatri di Rumah Sakit
- e. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan pelayanan Geriatri di Rumah Sakit dari unit-unit kerja di lingkungan RS Prima husada

Tim PKBRS
Pasal 71

1. Tim PKBRS merupakan bagian dari program Keluarga Berencana (KB), yang sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu
2. Tim PKBRS mempunyai tugas:
 - a. Membuat rencana program kerja Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS)
 - b. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS)
 - c. Melakukan administrasi dan pengarsipan terkait tim PKBRS
 - d. Melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan KB secara terpadu dan paripurna
 - e. Mengembangkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan KB dan meningkatkan kualitas pelayanan KB
 - f. Meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
3. Tim PKBRS mempunyai wewenang:
 - a. Menentukan agenda setiap rapat Tim Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS)
 - b. Memerintahkan dan menugaskan staf dalam melaksanakan Program pelayanan kesehatan KB
 - c. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan RS Prima husadaterkait pelaksanaan program pelayanan KB di rumah sakit
 - d. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan pelayanan Kesehatan KB di rumah sakit dari unit-unit kerja di lingkungan RS Prima husada
 - e. Melakukan koordinasi dengan unit – unit kerja di lingkungan RS Prima husada terkait pelaksanaan investigasi terhadap pelayanan KB

Tim Stunting dan Wasting
Pasal 72

1. Tim Stunting dan Wasting merupakan salah satu program untuk menurunkan prevalensi stunting dan wasting di Rumah Sakit
2. Tim Stunting dan Wasting mempunyai tugas:
 - a. Membuat rencana program kerja Tim Stunting dan Wasting
 - b. Melaksanakan semua program Tim Stunting dan Wasting
 - c. Membantu pembuatan pedoman kerja tim Stunting dan Wasting
 - d. Membantu pembuatan SPO terkait kegiatan program Layanan Kesehatan dan Gizi Cegah Stunting Sejak Dini
 - e. Membuat Materi edukasi bentuk apapun untuk kebutuhan KIE pasien dan keluarga untuk peningkatan kualitas gizi dalam upaya preventif, promotif, kuratif.
 - f. Melakukan monitoring dan investigasi terhadap pelayanan kesehatan dan gizi cegah stunting di rumahsakit dari unit kerja terkait

- g. Melakukan pemantauan ke FKTP dan Komunitas terkait pelayanan kesehatan dan gizi stunting
 - h. Mengusulkan tindak lanjut dari hasil analisis pelayanan kesehatan dan gizi cegah stunting
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan Stunting dan Wasting di Rumah Sakit Prima husada.
3. Tim Stunting dan Wasting mempunyai wewenang:
- a. Menentukan agenda setiap rapat Tim Stunting dan Wasting
 - b. Memerintahkan dan menugaskan staf dalam melaksanakan Program pelayanan kesehatan dan gizi Stunting
 - c. Meminta data dan informasi dari anggota terkait program stunting dan wasting
 - d. Memutuskan kebijakan yang berlaku untuk program Stunting dan Wasting sesuai perundangan atau regulasi yang berlaku
 - e. Meminta laporan pelaksanaan program pelayanan Kesehatan dan Gizi Cegah Stunting di rumah sakit dari unit kerja pelaksana/ terkait
 - f. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan RS Prima husada terkait pelaksana program pelayanan Kesehatan dan Gizi Cegah Stunting di rumah sakit
 - g. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan pelayanan Kesehatan dan Gizi Cegah Stunting di rumah sakit dari unit-unit kerja di lingkungan RS Prima husada.

Tim HTA

Pasal 73

- 1. Tim HTA bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pelaksanaan program Penampisan Teknologi Kesehatan
- 2. Tim HTA mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengembangan kompetensi anggota tim dan staf operasional tim
 - b. Melakukan pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan Program Penampisan Teknologi Kesehatan untuk jangka waktu tertentu
 - c. Melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan laporan hasil kegiatan serta penyediaan data dan informasi kegiatan
 - d. Melakukan penilaian, pengkajian terhadap teknologi di RS
 - e. Melakukan penilaian dan memutuskan hasil penilaian yang adekuat
 - f. Melaporkan hasil penilaian dan menyampaikan rekomendasi terkait Penapisan Teknologi Kesehatan
- 3. Tim HTA mempunyai wewenang:
 - a. Mengatur dan melaksanakan penilaian, pengkajian, pelaporan tentang alat kesehatan
 - b. Menentukan/ memilih mitra bestari (peer group) untuk melakukan penilaian
 - c. Melakukan koordinasi dengan tim ahli dalam permohonan rekomendasi

BAB VIII

STAF MEDIS FUNGSIONAL

Pasal 74

- 1. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- 2. Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan,

pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

3. Dalam melaksanakan tugasnya staf medis fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

BAB IX INSTALASI

Pasal 75

4. Instalasi dibentuk sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan.
5. Rumah Sakit Prima husada membentuk Instalasi yang terdiri dari 3 (tiga) unsur pelayanan medis, unsur penunjang medis dan unsur penunjang umum:

Unsur pelayanan medis terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap;
- c. Instalasi Gawat Darurat;
- d. Instalasi ICU;
- e. Instalasi Kamar Operasi.

Unsur penunjang medis terdiri dari :

- a. Instalasi Radiologi;
- b. Instalasi Farmasi;
- c. Instalasi Laboratorium;
- d. Instalasi Gizi.

Unsur penunjang umum adalah

- a. Instalasi IPSRS;
- b. Instalasi Laundry;
- c. Instalasi CSSD/

6. Setiap penyusunan dan tata kerja instalasi rumah sakit harus didasarkan pada penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan cross functional approach secara vertikal dan horizontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
7. Pembentukan instalasi ditetapkan dengan Direktur.
8. Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi Rumah Sakit.
9. Direktur dalam tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau tenaga non fungsional.
10. Direktur mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi instalasi masing-masing.
11. Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.

BAB X KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 76

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
2. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.

3. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Masing-masing tenaga fungsional dimaksud berada dilingkungan unit kerja rumah sakit sesuai kompetensinya.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 77

1. Dalam rangka melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Rumah Sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi (cross function approach) secara vertikal dan horisontal baik dilingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing.
2. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
4. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala.
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
6. Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasannya masing-masing.

BAB XII PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Pasal 78 Tujuan Pengelolaan

Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pasal 79 Pengangkatan Pegawai

1. Pengangkatan pegawai Rumah Sakit Prima husada yang berasal dari pegawai kontrak dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
2. Mekanisme pengangkatan pegawai yang berasal dari pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 80
Perpindahan Pegawai

1. Perpindahan Pegawai di lingkungan Rumah Sakit dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
2. Perpindahan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
 - b. Masa kerja di unit tertentu;
 - c. Pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. Kegunaannya dalam menunjang karir;
 - e. Kondisi fisik dan psikis pegawai.

Pasal 81
Pemberhentian Pegawai

1. Pemberhentian pegawai berstatus kontrak/ tetap sesuai dengan peraturan tentang pemberhentian.
2. Pemberhentian pegawai berstatus kontrak/ tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Mencapai batas usia 56 tahun;
 - d. Perampingan organisasi Rumah Sakit;
 - e. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat

BAB XIII
PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS
(MEDICAL STAF BYLAWS)

Pasal 82
Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Peraturan Internal Staf Medis adalah agar Komite Medik dapat menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance) melalui mekanisme kredensial, peningkatan mutu profesi, dan penegakan disiplin profesi.
2. Tujuan dari Peraturan Internal Staf Medik meliputi:
 - a. Tercapainya kerjasama yang baik antara staf medik dengan Direktur Rumah Sakit;
 - b. Tercapainya sinergisme antara manajemen dan profesi medis untuk kepentingan pasien;
 - c. Terciptanya tanggung jawab staf medik terhadap mutu pelayanan medis di Rumah Sakit.

BAB XIV
KEWENANGAN KLINIS
(CLINICAL PRIVILEGE)

Pasal 83
Kewenangan Klinis

1. Semua pelayanan medis hanya boleh dilakukan oleh staf medis yang telah diberi Kewenangan Klinis oleh Direktur Rumah Sakit.

2. Setiap tenaga medis yang diberi kewenangan klinis oleh Direktur rumah sakit wajib menandatangani perjanjian sesuai dengan regulasi rumah sakit.
3. Kewenangan Klinis seperti dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Surat Penugasan Klinis (SPK) dan Rincian Kewenangan Klinis (RKK).
4. Kewenangan Klinis diberikan oleh Direktur Rumah Sakit atas rekomendasi Komite Medik melalui Subkomite Kredensial sesuai dengan Prosedur Penerimaan Anggota SMF.
5. Kewenangan Klinis diberikan kepada seorang anggota SMF untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
6. Pemberian Kewenangan Klinis ulang dapat diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat dengan mengikuti prosedur Rekredensial dari Subkomite Kredensial Komite Medik

Pasal 84

Proses Penilaian Kewenangan Klinis

Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memberikan rekomendasi Kewenangan Klinis:

1. Pendidikan:
 - a. Lulus dari sekolah kedokteran yang terakreditasi;
 - b. Menyelesaikan program pendidikan kedokteran.
2. Perizinan (lisensi):
 - a. Memiliki surat tanda registrasi yang sesuai dengan bidang profesi;
 - b. Memiliki izin praktek dari Dinas Kesehatan setempat yang masih berlaku.
3. Kegiatan penjagaan mutu profesi:
 - a. Menjadi anggota organisasi yang melakukan penilaian kompetensi bagi anggotanya;
 - b. Berpartisipasi aktif dalam proses evaluasi mutu klinis.
4. Kualifikasi personal:
 - a. Riwayat disiplin dan etik profesi;
 - b. Keanggotaan dalam perhimpunan profesi yang diakui;
 - c. Keadaan sehat jasmani dan mental, termasuk tidak terlibat penggunaan obat terlarang dan alkohol yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pasien;
 - d. Riwayat keterlibatan dalam tindakan kekerasan; dan
 - e. Memiliki asuransi proteksi profesi.
5. Pengalaman di bidang keprofesian:
 - a. Riwayat tempat pelaksanaan praktik profesi;
 - b. Riwayat tuntutan medis atau klaim oleh pasien selama menjalankan profesi.

Pasal 85

Pembatasan Kewenangan Klinis

1. Komite Medik bila memandang perlu dapat memberi rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit agar Kewenangan Klinis anggota SMF dibatasi berdasarkan atas keputusan dari Subkomite Kredensial;
2. Pembatasan Kewenangan Klinis ini dapat dipertimbangkan bila anggota SMF tersebut dalam pelaksanaan tugasnya di Rumah Sakit dianggap tidak sesuai dengan standar pelayanan medis dan standar prosedur operasional yang berlaku, dapat dipandang dari sudut kinerja klinik, sudut etik dan disiplin profesi medis dan dari sudut hukum;
3. Subkomite Kredensial membuat rekomendasi pembatasan Kewenangan Klinis anggota SMF setelah terlebih dahulu:

- a. Ketua SMF mengajukan surat untuk mempertimbangkan pencabutan Kewenangan Klinis dari anggotanya kepada Ketua Komite Medik;
- b. Komite Medik meneruskan permohonan tersebut kepada Subkomite Kredensial untuk meneliti kinerja klinis, etika dan disiplin profesi medis anggota SMF yang bersangkutan;
- c. Subkomite Kredensial berhak memanggil anggota SMF yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan membela diri setelah sebelumnya diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari bukti- bukti tertulis tentang pelanggaran/ penyimpangan yang telah dilakukan;
- d. Subkomite Kredensial dapat meminta pendapat dari pihak lain yang terkait.

Pasal 86

Pencabutan Kewenangan Klinis

1. Pencabutan Kewenangan Klinis dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit atas rekomendasi Komite Medik yang berdasarkan usulan dari Subkomite Etika dan Disiplin Profesi dan Subkomite Kredensial.
2. Pencabutan Kewenangan Klinis dilaksanakan apabila:
 - a. Adanya gangguan kesehatan (fisik dan mental);
 - b. Adanya kecelakaan medis yang diduga karena inkompetensi;
 - c. Mendapat tindakan disiplin dari Komite Medik.

Pasal 87

Pengakhiran Kewenangan Klinis

1. Pengakhiran Kewenangan Klinis dilaksanakan oleh Direktur Rumah Sakit atas rekomendasi Komite Medik yang berdasarkan usulan dari Subkomite Etika dan Disiplin profesi dan Subkomite Kredensial.
2. Pengakhiran Kewenangan Klinis dilaksanakan apabila Surat Penugasan Klinis (SPK):
 - a. Habis masa berlakunya;
 - b. Dicabut sesuai pasal 79 ayat (2).
3. Pengakhiran kewenangan klinis dilaksanakan apabila masa berlaku Perjanjian Kerja Sama antara staf medis dan rumah sakit telah berakhir.

BAB XV

PENUGASAN KLINIS

Pasal 88

1. Setiap staf medis yang melakukan asuhan medis harus memiliki Surat Penugasan Klinis (SPK) dari Direktur Rumah Sakit berdasarkan rincian Kewenangan Klinis setiap staf medis yang direkomendasikan Komite Medik.
2. Tanpa Surat Penugasan Klinis (SPK) maka seorang staf medis tidak dapat menjadi anggota kelompok (member) staf medis sehingga tidak boleh melakukan pelayanan medis di Rumah Sakit.

BAB XVI
PERATURAN TATA KELOLA KLINIS**Pasal 89**

Untuk melaksanakan tata kelola klinis diperlukan aturan-aturan profesi bagi staf medis secara tersendiri diluar peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws). Aturan profesi tersebut antara lain:

1. Pemberian pelayanan medis dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
2. Kewajiban melakukan konsultasi dan/ atau merujuk pasien kepada dokter, dokter spesialis dengan disiplin yang sesuai;
3. Kewajiban melakukan pemeriksaan patologi anatomi terhadap semua jaringan yang dikeluarkan dari tubuh dengan pengecualiannya.

BAB XVII
TATA CARA REVIEW DAN PERBAIKAN PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS**Pasal 90**

1. Perubahan terhadap Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) dapat dilakukan berdasarkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya;
2. Waktu perubahan peraturan internal staf medis ini dilakukan paling lama setiap 3 (tiga) tahun;
3. Perubahan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Medik Rumah Sakit;
4. Mekanisme perubahan Peraturan Internal Staf Medis dilakukan dengan melibatkan seluruh staf medis dan staf manajemen terkait melalui lokakarya dan terakhir disahkan oleh Direktur Rumah Sakit.

BAB XVIII
STAF MEDIS**Pasal 91**

1. Tujuan umum pengorganisasian staf medis adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pendidikan Rumah Sakit.
2. Tujuan Khusus adalah :
 - a. Tercapainya kerjasama yang baik antara staf medis, pemilik Rumah Sakit ataupun yang mewakili dan Direktur.
 - b. Tercapainya sinergi antara manajemen dan staf medis untuk kepentingan pasien.
 - c. Tercapainya tanggung jawab staf medis terhadap mutu pelayanan medis dan pendidikan di Rumah Sakit.

Pasal 92
Tanggung Jawab Staf Medis

Kelompok staf medis mempunyai tanggung jawab yang terkait dengan mutu, etik, pelayanan dan pengembangan pendidikan Staf Medis. Tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit melalui Ketua Komite Medis/ Sub Komite Kredensial terhadap permohonan penempatan dokter baru dan penempatan ulang dokter di Rumah Sakit. Untuk membuat Surat Keputusan

- tersebut Direktur Rumah Sakit perlu meminta masukan dari kelompok Staf Medis/ Sub Komite Kredensial.
2. Melakukan evaluasi kinerja praktik dokter berdasarkan data yang komprehensif.
 3. Memberikan kesempatan bagi para dokter untuk mengikuti pengembangan profesi berkelanjutan (Continuing Profesional Development)
 4. Memberikan rekomendasi dan masukan kepada Direktur Rumah Sakit melalui Komite Medis hal- hal yang terkait dengan praktik kedokteran.
 5. Memberikan laporan tentang hasil pemantauan indikator mutu klinik, hasil evaluasi kinerja praktik klinis, pelaksanaan program pengembangan staf medis dan lain-lain kepada Direktur melalui Ketua Komite Medis.
 6. Melakukan perbaikan (*updating*) Standar Prosedur Operasional dan Dokumen terkaitnya.

Pasal 93

Proses Penerimaan, Pengangkatan Staf Medis dan Pengangkatan Kembali Staf Medis

Tata cara dan persyaratan penerimaan, pengangkatan dan pengangkatan kembali staf medis secara administrasi dan kompetensi mengikuti tata cara yang berlaku sesuai dengan kebijakan rumah sakit dan konsisten dengan populasi pasien rumah sakit, misi serta pelayanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pasien.

Pasal 94

Kategori Staf Medis

Adalah kelompok Staf Medis dan Komite Medis yang meliputi dokter tetap, dokter paruh waktu, dokter tamu, dokter umum di unit gawat darurat, dokter umum di pelayanan intensif serta wadah profesional medis.

Pasal 95

Dokter Tetap

Dokter tetap adalah dokter yang direkrut oleh Rumah Sakit Prima husada sebagai pegawai tetap dan berkedudukan sebagai sub ordinat , yaitu bekerja untuk dan atas nama Rumah Sakit serta bertanggungjawab kepada Direksi Rumah Sakit. Kualifikasi dokter tetap sesuai dengan kompetensi dibidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban yang di atur dalam ketentuan tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

Dokter Tamu

Dokter tamu adalah dokter yang karena reputasi atau keahliannya diundang secara khusus oleh Rumah Sakit untuk menangani atau membantu menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh Staf Medis fungsional lain yang ada atau untuk mendemonstrasikan suatu teknologi baru.

Pasal 98

Dokter Umum di Instalasi Gawat Darurat

Dokter Umum di Instalasi Gawat Darurat adalah dokter Umum yang memberikan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat sesuai dengan penempatan dan atau tugas yang

diberikan oleh Rumah Sakit. Kualifikasi Dokter Umum tersebut adalah sesuai dengan kompetensi dibidangnya serta mempunyai hak dan kewajiban yang sesuai dengan kompetensi dibidangnya serta hak dan kewajiban yang di atur dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 99

Dokter Umum di Ruang Rawat Inap

Dokter Umum di Ruang Rawat Inap adalah dokter umum yang memberikan pelayanan di Instalasi Rawat Inap sesuai tugas yang memberikan pelayanan di Instalasi Rawat Inap sesuai tugas yang diberikan oleh Rumah Sakit. Kualifikasi dokter umum tersebut adalah kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 100

Pembinaan

Pembinaan dalam proses penyelesaian dalam kasus yang terjadi dan muncul dalam kegiatan pelayanan medis berjenjang adalah:

1. Laporan kejadian (oleh siapapun) harus menjadi perhatian staf medis di lingkungan itu untuk selanjutnya disampaikan Ketua Kelompok, Komite Medis Direktur/ Kabid Pelayanan.
2. Ketua Kelompok berkepentingan untuk menjaga martabat kelompok dikalangan sesama staf medis maupun di kalangan staf lain dirumah sakit dan perlu menghubungi yang bersangkutan untuk memperoleh informasi pembandingan.
3. Komite Medis memperhatikan mekanisme audit medis melalui kerjasama baik dalam direktur untuk mendorong pengumpulan data dari unsur terkait (staf keperawatan, staf laboratorium, staf radiologi maupun regu jaga).
4. Apabila data yang diperlukan dinilai sudah lengkap, harus dilaksanakan rapat klinik multi-disiplin secepatnya dengan atau tanpa mengundang pers.
5. Rapat klinik yang demikian mempertajam kajian dignosa, prosedur pelayanan, ketepatan tindakan/ pengobatan.
6. Hasil rapat klinik harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki mutu.
7. Sanksi profesional dan atau administratif akan dilakukan dengan hati-hati.

Pasal 101

Pengorganisasian Staf Medis

Prinsip-prinsip pengorganisasian :

1. Dokter, dokter gigi, dokter spesialis (purna waktu dan paruh waktu) yang bekerja di unit pelayanan rumah sakit wajib menjadi anggota staf medis.
2. Dalam melaksanakan tugas staf medis, dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahlian dengan cara lain dengan pertimbangan khusus.
3. Setiap kelompok staf medis minimal terdiri dari (dua) orang dokter.
4. Pengelompokan staf medis berdasarkan spesialis/ keahlian adalah tenaga dokter dengan spesialis/ keahlian yang sama dikelompokkan kedalam 1 (satu) kelompok staf medis.
5. Pengelompokan staf medis dengan cara lain dengan pertimbangan khusus dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :
 - a. Penggabungan tenaga dokter spesialis dengan spesialis/ keahlian yang berbeda. Penggabungan ini dilakukan karena jumlah dokter spesialis tersebut kurang dari 2 (dua) orang

- b. sehingga tidak memungkinkan untuk membentuk staf medis sendiri. Penggabungan harus memperhatikan kedekatan disiplin ilmu tersebut dan wajib diikuti dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas serta dituangkan didalam kebijakan dan prosedur pelayanan medis rumah sakit.
- c. Penggabungan tenaga dokter spesialis dengan memperhatikan tugas dan wewenang dokter spesialis tersebut. Penggabungan ini dilakukan karena jumlah dokter spesialis yang sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan masing-masing jenis spesialis/ keahlian membentuk kelompok staf medis tersendiri. Karena itu rumah sakit hanya membentuk 2 (dua) kelompok staf medis yaitu kelompok staf medis bedah dan kelompok staf medis non bedah. Dokter spesialis yang melaksanakan tindakan medis operatif (misal dokter bedah, dokter obgin dan lain sebagainya) dikelompokkan ke dalam staf medis bedah sedangkan tenaga dokter yang hanya melaksanakan tindakan medis non operatif dikelompokkan ke dalam kelompok staf Medis Non Bedah.
- d. Pembentukan staf medis untuk Dokter Umum dapat dilakukan dengan membentuk kelompok Medis dokter Umum sendiri atau bergabung dengan kelompok staf Medis dimana dokter umum tersebut memberikan pelayanan. Penggabungan dokter umum dengan dokter spesialis dapat dilakukan apabila jumlah dokter spesialis masih kurang sehingga tidak memungkinkan membentuk staf Medis sendiri. Penggabungan dokter spesialis dan dokter umum harus diikuti dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelayanan Medis rumah sakit.
- e. Dokter gigi dapat menjadi kelompok staf Medis sendiri atau bergabung dengan staf kelompok Medis bedah/ staf kelompok staf medis dokter umum, dokter gigi. Penggabungan dilakukan apabila dokter gigi masih kurang dari 2 (dua) orang. Yang perlu diperhatikan, penggabungan dokter gigi dengan dokter spesialis lainnya wajib diikuti dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas yang dituangkan di dalam kebijakan dan prosedur pelayanan medis rumah sakit.

Pasal 102

Penempatan Kelompok Staf Medis

1. Penempatan para dokter kedalam kelompok staf Medis sebagaimana tersebut diatas di tetapkan dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit atas usulan Ketua Komite Medis.
2. Dalam surat keputusan tersebut hendaknya dilengkapi dengan perjanjian kerja masing-masing dokter sehingga ada kejelasan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 103

Pemilihan Ketua Kelompok Staf Medis

1. Kelompok staf Medis di pimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya.
2. Kelompok staf Medis dapat beranggotakan dokter purna waktu atau dokter paruh waktu.
3. Pemilihan ketua kelompok staf Medis diatur dengan mekanisme yang disusun oleh Komite Medis. Proses pemilihan ini wajib melibatkan Direktur Rumah Sakit. Setelah proses pemilihan Ketua Staf Medis selesai maka penetapan sebagai Ketua Staf Medis disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit.
4. Masa bakti Kelompok Staf Medis adalah minimal 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode berikutnya berturut-turut.

Pasal 104**Tujuan dan Fungsi Kelompok Staf Medis**

1. Tugas ketua kelompok staf Medis adalah menyusun uraian tugas, wewenang dan tata kerja staf medis yang di pimpinnya.
2. Uraian tugas dan wewenang ditetapkan secara individu untuk masing- masing dokter.

Pasal 105**Hubungan Kerja Kelompok Staf Medis**

Kelompok Staf Medis secara administratif bertanggungjawab kepada Direktur dan Kabid pelayanan, sedangkan secara fungsional sebagai profesi bertanggung jawab pada komite medis melalui ketua Kelompok Staf Medis.

Pasal 106**Penilaian Kinerja**

1. Penilaian Kinerja yang bersifat administratif, misalnya mengenai disiplin kepegawaian, motivasi kinerja dan lain sebagainya di lakukan oleh Direktur Rumah Sakit.
2. Evaluasi yang menyangkut keprofesian, misalnya audit medis, peer review disiplin profesi, etika profesi dan lain sebagainya dilakukan oleh Komite Medis.
3. Berdasarkan ayat 1 dan ayat 2, staf Medis yang memberikan pelayanan medis menetap di unit tertentu secara fungsional, profesi tetap menjadi tanggung jawab Komite Medis khususnya dalam pembinaan masalah etik , mutu dan pengembangan ilmu dan administrasi dibawah kepala Instalasi.

Pasal 107**Tugas dan Fungsi Staf Medis**

1. Staf Medis Mempunyai Fungsi Sebagai Pelaksanaan Pelayanan Medis, Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan dibidang medis.
2. Tugas staf Medis :
 - a. Melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan.
 - b. Meningkatkan kemampuan profesinya melalui progam pendidikan/ pendidikan berkelanjutan.
 - c. Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan.
 - d. Menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinik.

Pasal 108**Kewenangan Staf Medis**

Kewenangan masing-masing anggota Kelompok Staf Medis disusun oleh Ketua Kelompok Staf Medis dan kemudian diusulkan oleh Ketua Komite Medis kepada Direktur Rumah Sakit untuk dibuat Surat Keputusan.

Pasal 109**Tanggung Jawab Staf Medis**

Kelompok Staf Medis mempunyai tanggung jawab yang dikaitkan dengan mutu, etik, dan pengembangan pendidikan Staf Medis. Tanggung jawab tersebut sebagai berikut:

1. Membeikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis/ Sub Komite Kredensial kepada Direktur Rumah Sakit terhadap permohonan penempatan Dokter Baru. Penempatan Dokter di Rumah Sakit berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit. Untuk membuat Surat Keputusan tersebut Direktur Rumah Sakit perlu meminta masukan dari Organisasi Staf Medis/ Sub Komite Kredensial.
2. Melakukan evaluasi kinerja praktek dokter berdasarkan data yang komprehensif. Evaluasi kinerja praktek dilakukan melalui peer Review, audit medis atau program quality improverment.
3. Memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medis/ Sub Komite Kredensial kepada Direktur Rumah Sakit terhadap permohonan penempatan ulang dokter di Rumah Sakit. Penempatan ulang Dokter di Rumah Sakit berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit, untuk membuat Surat Keputusan Tersebut direktur rumah sakit perlu meminta masukan dari organisasi staf medis/ sub komite kredensial.
4. Memberi kesempatan bagi para dokter untuk mengikuti “continuing professional develapment” (CPD). Masing-masing kelompok staf medis wajib mempunyai program (CPD) bagi semua anggotanya.
5. Memberikan masukan kepada Direktur Rumah Sakit melalui Komite Medis hal-hal yang terkait dengan praktik kedokteran. Kelompok Staf Medis mempunyai tanggung jawab memberikan masukan kepada Direktur Rumah Sakit mengenai hal-hal yang terkait dengan praktik kedokteran. Misalnya mengenai perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, temuan terapi yang baru dan lain- lain.
6. Melakukan perbaikan (updating) standar operasional prosedur dan dokumen terkaitnya. Standar Operasional Prosedur dan dokumen terkait lainnya perlu disempurnakan secara berkala sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi.

Pasal 110
Kewajiban Staf Medis

1. Menyusun standar Prosedur Operasional pelayanan medis yang terdiri dari :
 - a. Standar Prosedur Operasional dibidang administrasi/ menejerial antara lain meliputi pengaturan tugas rawat jalan. Pengaturan tugas rawat inap, pengaturan tugas jaga, pengaturan tugas rawat intensif, pengaturan tugas dikamar operasi, kamar bersalin dan lain sebagainya, pengaturan visite/ shift, pertemuan klinik, presentasi kasus (kasus kematian, kasus sulit, kasus langka, kasus penyakit tertentu), prosedur konsultasi dan lain-lain. Penyusunan Standar Prosedur Operasional ini dibawah koordinasi Direktur Rumah Sakit.
 - b. Standar Prosedur Operasional pelayanan Medis di bidang keilmuan/ keprofesian adalah standar pelayanan medis yang dibuat oleh Kelompok Staf Medis, antara lain meliputi tata cara pemeriksaan penyakit sampai dengan penatalaksanaan serta pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Masing-masing Kelompok Staf Medis menyusun standar pelaksanaan medis minimal untuk 10 jenis penyakit. Penyusun Standar Prosedur Operasional ini dibawah Koordinasi Komite Medis.
2. Menyusun indikator mutu klinis. Masing-masing kelompok staf medis menyusun minimal 3 (tiga) jenis indikator mutu output atau outcome.
3. Menyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing anggotanya.
4. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
5. Merujuk pasien kedokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.

6. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal.
7. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali ia yakin ada orang yang bertugas dan mampu melakukannya.
8. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.
9. Menunjuk staf medis lain dalam keahlian yang sama sebagai pengganti apabila berhalangan jika tidak harus dikonfirmasi kepada pasien yang bersangkutan.
10. Memberikan penjelasan secara lengkap kepada pasien sebelum persetujuan tindakan disetujui pasien (informed consent).
11. Membuat rekam medis dan mematuhi petunjuk pelaksanaannya.
12. Menyelenggarakan pengendali mutu dan pengendali biaya.
13. Mematuhi kebijakan rumah sakit tentang obat dan formularium rumah sakit.

BAB XIX KEPENGAWASAN

Pasal 111 Kepengawasan

1. Evaluasi kinerja praktek dokter dilakukan melalui peer review, audit medis atau program quality improvement.
2. Kelompok Staf Medis mempunyai tanggung jawab memberi masukan kepada Direktur Rumah Sakit mengenai hal-hal yang terkait dengan praktek kedokteran. Misalnya mengenai pengembangan ilmu dan teknologi kedokteran, temuan yang baru dan lain-lain.

Pasal 112 Ketentuan Perubahan

1. Peraturan Internal Staf Medis dapat dilakukan perubahan/ penambahan melalui rapat khusus dari Perseroan Terbatas Disa Prima Medika atau yang mewakili dengan Direksi Rumah Sakit yang diselenggarakan untuk itu.
2. Perubahan dan penambahan Peraturan Internal Staf Medis sebagaimana tersebut ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan perubahan/ penambahan tersebut.

BAB XX KERAHASIAAN INFORMASI MEDIS

Pasal 113 Kerahasiaan Pasien

1. Setiap pegawai rumah sakit wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang pasien;
2. Pemberian informasi medis yang menyangkut kerahasiaan pasien hanya dapat diberikan atas persetujuan Direktur atau Kepala Bidang Pelayanan.

Pasal 114 Informasi Medis

1. Hak-hak pasien yang dimaksud adalah hak-hak pasien sebagaimana yang terdapat didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Informasi medis yang harus diungkapkan dengan jujur dan benar adalah mengenai:
 - a. Keadaan kesehatan pasien;
 - b. Rencana terapi dan alternatifnya;

- c. Manfaat dan resiko masing-masing alternatif tindakan;
- d. Prognosis; dan
- e. Kemungkinan Komplikasi.

Pasal 115

Hak dan Kewajiban Pasien

1. Hak pasien meliputi:
 - a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 - b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
 - c. Memperoleh layanan kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
 - d. Memperoleh layanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - e. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai standar prosedural operasional, membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
 - f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapat;
 - g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 - h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Ijin Praktik (slp) baik dalam maupun di luar Rumah Sakit;
 - i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
 - j. Mendapat informasi yang mengenai diagnosa dan tata cara tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
 - k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
 - l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
 - m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
 - n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
 - o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
 - p. Menolak bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
 - q. Menggugat dan/ atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana, dan mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kewajiban Pasien meliputi :
 - a. Mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 - b. Menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggungjawab;
 - c. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Rumah Sakit;

- d. Menghormati informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatan;
- e. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimiliki;
- f. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya;
- h. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Pasal 116

Hak dan Kewajiban Dokter

1. Hak dokter meliputi :
 - a. Hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional;
 - b. Hak memberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional;
 - c. Hak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien; dan
 - d. Hak menerima imbalan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Kewajiban Dokter meliputi :
 - a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional serta kebutuhan medis;
 - b. Merujuk ke dokter lain, bila tidak mampu;
 - c. Merahasiakan informasi pasien, meskipun pasien sudah meninggal;
 - d. Melakukan pertolongan darurat, kecuali bila yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu; dan
 - e. Menambah IPTEK dan mengikuti perkembangan.

Pasal 117

Hak dan Kewajiban Rumah Sakit

1. Hak Rumah Sakit meliputi:
 - a. Menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;
 - b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi/jasa pelayanan, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
 - d. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
 - f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
 - g. Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kewajiban Rumah Sakit meliputi:
 - a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;

- b. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan dengan kemampuan pelayanannya;
- e. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/ miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- g. Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- h. Menyelenggarakan rekam medis;
- i. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
- j. Melaksanakan sistem rujukan;
- k. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- l. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- m. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- n. Melaksanakan etika Rumah Sakit;
- o. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- p. Melaksanakan program pemerintah dibidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- q. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya;
- r. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws);
- s. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
- t. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

BAB XXI KEBIJAKAN, PEDOMAN DAN PROSEDUR

Pasal 118

1. Kebijakan, Pedoman/ Panduan, dan Prosedur merupakan kelompok dokumen regulasi Rumah Sakit sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan;
2. Kebijakan merupakan regulasi tertinggi di Rumah Sakit kemudian diikuti dengan Pedoman/ Panduan dan selanjutnya Prosedur/ Standar Prosedur Operasional (SPO);
3. Review dan persetujuan atas kebijakan, pedoman/ panduan dan prosedur di rumah sakit harus melalui rapat koordinasi dalam bidang Administrasi dan Sumber Daya yang berwenang;
4. Review dan persetujuan atas kebijakan, pedoman/ panduan dan prosedur dalam bidang Pelayanan Medik yang berwenang sebelum diterbitkan adalah Kepala Bidang Pelayanan;

5. Proses dan frekuensi review serta persetujuan berkelanjutan atas kebijakan, pedoman/ panduan dan prosedur dilakukan minimal setiap 3 (tiga) tahun sekali dan atau bila terdapat perubahan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Pengendalian untuk menjamin bahwa hanya kebijakan, pedoman/ panduan dan prosedur terkini, dengan versi yang relevan tersedia pada unit pelaksana dilakukan melalui dokumen terkendali;
7. Identifikasi perubahan dalam kebijakan, pedoman/ panduan dan prosedur dilakukan oleh Unit Pelaksana secara berjenjang sesuai hierarkhi struktural;
8. Pemeliharaan identitas dan dokumen yang bisa dibaca harus diletakkan ditempat yang mudah dilihat, mudah diambil dan mudah dibaca oleh pelaksana;
9. Pengelolaan kebijakan, pedoman/ panduan dan prosedur yang berasal dari luar rumah sakit yang dijadikan acuan dikendalikan dengan mempergunakan Dokumen melalui catatan formulir Master List Dokumen Eksternal;
10. Retensi dari kebijakan, pedoman/ panduan dan prosedur yang sudah tidak berlaku mengacu pada Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang Retensi Dan Penyusutan Arsip Non Rekam Medis;
11. Identifikasi dan penelusuran dari sirkulasi seluruh kebijakan dan prosedur mempergunakan buku registrasi dan master list yang dikelola oleh kepala budang.

BAB XXII KERJASAMA/ KONTRAK

Pasal 119

1. Direktur Rumah Sakit menjamin keberlangsungan pelayanan klinis dan manajemen yang memenuhi kebutuhan pasien yang dapat dilakukan dengan jalan melalui perjanjian kerjasama/ kontrak;
2. Para pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama/ kontrak mengenai objek tertentu;
3. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima rencana kerja sama/ kontrak tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama/kontrak yang paling sedikit memuat:
 - a. Subyek kerja sama/ kontrak;
 - b. Obyek kerja sama/ kontrak;
 - c. Ruang lingkup kerja sama/ kontrak;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Jangka waktu kerja sama/ kontrak;
 - f. Pengakhiran kerja sama/ kontrak.
 - g. Keadaan memaksa;
 - h. Penyelesaian perselisihan.
4. Isi materi perjanjian kerjasama/ kontrak dikoreksi dan disepakati melalui pembubuhan paraf/ fiat para pejabat yang benvenang yaitu:
 - a. Kontrak klinis
Diajukan oleh unit pelayanan secara berjenjang kepada pejabat berwenang sesuai hierarkhi pelayanan. Kabid Pelayanan berpartisipasi dalam seleksi kontrak klinis dan bertanggung jawab atas kontrak klinis;
 - b. Perjanjian Kontrak Klinis antara:
 - 1) RS dengan individu staf klinis berupa pakta integritas staf klinis untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan regulasi RS;
 - 2) RS dengan badan hukum berupa kerjasama jenis pelayanan klinis yang disediakan RS.
 - c. Kontrak manajemen

- 1) Diajukan oleh unit yang mengelola administrasi sumber daya secara berjejang kepada pejabat berwenang sesuai hierarkhi administrasi sumber daya, Kabid Pneunjang serta Kabid Umum dan Keuangan berpartisipasi dalam seleksi kontrak manajemen dan bertanggung jawab atas kontrak manajemen
- 2) RS bekerjasama dengan badan hukum menyediakan alat kesehatan (KSO) dan pelayanan non klinis.
5. Setelah dibubuhi parall fiat pada kedua belah pihak dan lanjut diberi nomor oleh para pihak serta menerangkan pengalihan tanggung jawab kepada pihak kedua.
6. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit dan para pihak yang berwenang dengan pemberian materai yang cukup.
7. Hasil kerjasama/ kontrak dapat berupa uang, surat berharga, barang, hasil pelayanan, pengobatan, laboratorium, jasa lainnya dan atau nonmaterial berupa keuntungan.
8. Hasil kerjasama/ kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa uang harus menjadi pendapatan Rumah Sakit sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Hasil kerjasama/ kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa barang harus dicatat sebagai aset Rumah Sakit secara proporsional sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
10. Hasil kerja sama/ kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa hasil pelayanan, pengobatan, laboratorium dan jasa lainnya harus sesuai dengan kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama/ kontrak yang telah ditandatangani atau sesuai hasil addendum.
11. Evaluasi kerjasama/ kontrak dilaksanakan oleh unit pelaksana yang diketahui secara berjenjang sesuai hierarkhi pejabat yang berwenang dan dimonitoring mutu kontraknya oleh Tim Komite Mutu.
12. Hasil evaluasi dan monitoring mutu pelayanan yang disediakan melalui kontrak tidak sesuai dengan kontrak maka Tim Komite Mutu meyarankan untuk memberi tergunan dan pemutusan kontrak.
13. Bila hasil evaluasi kerjasama/ kontrak dinegosiasi kembali, maka bisa dilakukan review kontrak untuk perpanjangan agar unit pelaksana dan para pejabat secara berjenjang menjaga kontinuitas pelayanan kepada pasien.

BAB XXIII PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 120 Perencanaan

1. Rumah sakit menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bisnis Rumah Sakit Prima husada;
2. Renstra bisnis Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan Rumah Sakit;
3. Visi sebagaimana dimaksud ayal (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan;
4. Misi sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan rumah sakit dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik;
5. Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul;

6. Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisa dan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja;
7. Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun;
8. Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 121
Penganggaran

1. Rumah sakit menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis Rumah Sakit;
2. Penyusunan Renstra Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan sumber-sumber pendapatan rumah sakit lainnya.

Pasal 122
Rencana Bisnis Anggaran

1. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit, memuat:
 - a. Kinerja tahunan berjalan;Asumsi makro dan mikro;
 - b. Target kinerja;
 - c. Analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - d. Perkiraan harga;
 - e. Anggaran pendapatan dan biaya;
 - f. Besaran persentase ambang batas;
 - g. Prognosis laporan keuangan;
 - h. Perkiraan maju (forward estimate);
 - i. Rencana pengeluaran investasi/modal.
2. Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 123
Persetujuan

1. Renstra bisnis Rumah Sakit mendapat persetujuan oleh Dewan Pengawas dan dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran serta evaluasi kinerja.
2. Rencana Bisnis dan Anggaran mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan rumah sakit dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan rumah sakit

BAB XXIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN KINERJA

Pasal 124
Pembinaan dan Pengawasan

1. Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan teknis Rumah Sakit dan pembinaan keuangan Rumah Sakit dilakukan oleh Direktur Utama PT. Disa Prima Medika.
2. Pengawasan Operasional rumah sakit dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal sebagai internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Direktur Rumah Sakit.
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit selain dilakukan oleh Direktur Utama PT. Disa Prima Medika, Internal Auditor juga dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 125
Evaluasi dan Penilaian Kinerja

1. Visi dan Misi dipergunakan sebagai pedoman untuk membuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penilaian kinerja bagi Rumah Sakit. Review/ perubahan Visi dan Misi dilakukan akibat terjadinya perubahan kebijakan oleh Pemilik.
2. Review/ perubahan Visi dan Misi Rumah Sakit diajukan oleh Direktur Rumah Sakit kepada Direktur Utama sesuai hasil rapat Tim Evaluasi Visi dan Misi
3. Visi dan Misi rumah sakit disahkan melalui Keputusan Direktur Utama dan dipublikasikan Humas Rumah Sakit.
4. Evaluasi dan penilaian kinerja Rumah Sakit dilakukan setiap tahun oleh Direktur Utama dan/ atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
5. Evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan Rumah Sakit sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.
6. Hasil pengukuran kinerja Rumah Sakit dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi disampaikan kepada Direktur Utama.

BAB XXV
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 126
Standar Pelayanan Minimal

1. Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan medik, keperawatan dan umum yang diberikan oleh Rumah Sakit Prima husada, Perseroan Terbatas Disa Prima Medika menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Prima husada sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Standar pelayanan minimal sebagaimana ayat (1), diusulkan oleh direksi Perseroan Terbatas Disa Prima Medika dan Rumah Sakit Prima husada.
3. Standar pelayanan minimal sebagaimana yang dimaksud ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, akreditasi, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan

Pasal 127
Syarat Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan:

1. Fokus pada jenis pelayanan yaitu mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi Rumah Sakit.

2. Terukur yakni sebagai kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai standar yang telah ditetapkan.
3. Dapat dicapai dengan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, kegiatan rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatan.
4. Relevan dan dapat diandalkan supaya sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi rumah sakit.
5. Tepat waktu yakni kesesuaian antara jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan

BAB XXVI TARIF LAYANAN

Pasal 128

1. Rumah Sakit Prima husada dalam melakukan layanan kesehatan dan memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan.
2. Imbalan atas barang dan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
3. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai imbalan hasil yang wajar dari investasi biaya per unit layanan.
4. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan Rumah Sakit Prima husada .

Pasal 129 Penetapan Tarif Layanan

1. Tarif layanan Rumah Sakit Prima husada diusulkan oleh Direktur kepada Direktur Utama berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan.
3. Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan masyarakat kompetisi yang sehat dibidang kesehatan.
4. Direktur dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dengan membentuk Tim Tarif Pelayanan.
5. Pemebentukan Tim tarif Pelayanan minimal terdiri dari: Keuangan, pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, umum dan Tim Perseroan Terbatas Disa Prima Medika

Pasal 130 Perubahan Tarif Layanan

1. Perubahan Tarif Layanan Rumah Sakit Prima husada dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan Perkembangan keadaan.
2. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
3. Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) berpredoman pada ketentuan tarif layanan.

**BAB XXVII
TUNTUTAN UMUM**

Pasal 131

1. Dalam hal pegawai Rumah Sakit dituntut berkaitan dengan hukum pidana, maka itu didasarkan pada tuntutananya.
2. Apabila tuntutan yang diajukan adalah kesalahan yang berkaitan dengan institusi, maka Rumah Sakit Prima husada bertanggungjawab selama kesalahan yang dilakukan masih mengikuti aturan atau Standar Prosedur Operasional (SPO).
3. Apabila tuntutan yang diajukan adalah kesalahan yang berkaitan dengan individu, maka Rumah Sakit Prima husada tidak bertanggung jawab selama kesalahan yang dilakukan tidak mengikuti aturan atau SPO yang diberlakukan.

**BAB XXVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 132

1. Struktur, nama, jumlah dan fungsi satuan organisasi fungsional lain yang tidak tercantum di dalam Hospital Bylaws sini ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Perubahan terhadap struktur, nama, jumlah dan fungsi satuan organisasi fungsional di lingkungan Rumah Sakit Prima husada ditetapkan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 133
Penutup**

1. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Baylaws) yang terdiri dari Corporate by Laws dan peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Peraturan ini berlaku 1 tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan peninjauan secara berkala, serta dapat diubah apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan rumah sakit, atau kebutuhan organisasi.
3. Perubahan Peraturan dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas dan atau atas usul Direktur.

Ditetapkan di Probolinggo,
Pada tanggal 18 Oktober 2025
Direktur PT Disa Prima Medika



dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE